

Livia de Oliveira Borges
Luciana Mourão
Organizadoras

O Trabalho e as Organizações

Atuações a partir da Psicologia





T758 O trabalho e as organizações [recurso eletrônico] : atuações a partir da psicologia / Organizadoras, Livia de Oliveira Borges, Luciana Mourão. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2013.

Editado também como livro impresso em 2013.
ISBN 978-85-65852-75-3

1. Psicologia. 2. Psicologia organizacional. I. Borges, Livia de Oliveira. II. Mourão, Luciana.

CDU 159:005.32

Catálogo na publicação: Ana Paula M. Magnus – CRB 10/2052

DIAGNÓSTICO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PSÍQUICA NO TRABALHO

Livia de Oliveira Borges
Liliana A. M. Guimarães
Sandra Souza da Silva

Introdução	581
Conceitos básicos e fundamentação.....	585
Abordagens individualistas	590
Psicodinâmica do trabalho	591
Abordagens psicossociológicas.....	594
O agir do psicólogo	599
Diagnóstico	599
Promoção da saúde psíquica	605
Considerações finais.....	611
Questões para discussão	612

INTRODUÇÃO

Elaboramos este capítulo com o objetivo de introduzir o psicólogo no campo da saúde psíquica e do trabalho de modo que possa identificar alternativas de ação, tendo em vista o diagnóstico, a prevenção, a assistência e a reabilitação da saúde psíquica no contexto do mundo do trabalho. Desde o

início do século passado, várias pesquisas e experiências de atuação do psicólogo vêm construindo o campo que aqui designamos saúde psíquica e trabalho. Entretanto, é a partir da década de 1980 que as publicações e as atuações do psicólogo nesse campo vêm se tornando regulares e diversificadas em suas abordagens epistêmicas e nos temas que focalizam, conforme tem sido des-

crito por várias publicações,* resgatando a história do campo. As tentativas de explicar as razões desse crescimento são muitas, entre as quais destacamos: as transformações epistêmicas da Psicologia Social, abrangendo a reflexão ética sobre a capacidade de a Psicologia responder aos problemas humanos concretos; as mudanças no próprio mundo do trabalho e das organizações que implicou atenção aos impactos da qualidade do desempenho profissional no bem-estar humano e vice-versa; e o reconhecimento dos transtornos psíquicos no trabalho como um problema efetivo de saúde pública e, ao mesmo tempo, do desenvolvimento das relações de trabalho.

Assim, entendemos que a consecução do objetivo mencionado para este capítulo apresenta relevância social por vários caminhos, tais como: o ético e de promoção do compromisso social do psicólogo; o da promoção saudável do desempenho no trabalho, seja no âmbito organizacional, seja em outras formas autônomas e emergentes de trabalho; e o da contribuição para melhoria das relações de trabalho, sobretudo no que se refere à segurança e à saúde do trabalhador. Entretanto, os avanços de compreensão sobre a saúde psíquica no trabalho têm ocorrido em um cenário técnico-científico permeado por muitas divergências, que certamente tem servido também de estímulo ao florescimento do campo do saber e de atuação. Isso significa que persistem tensões em pontos fundamentais. Começare-

mos, então, discorrendo sobre tais tensões como uma forma de seguir esclarecendo a relevância de nosso objetivo, bem como de, paulatinamente, ir apresentando os eixos de diferenciação das abordagens adotadas pelos psicólogos no diagnóstico e na promoção da saúde psíquica.

Uma primeira tensão (Fig. 20.1) diz respeito à própria constituição do campo: para que se reconheça sua existência, consideramos necessário assumir, como pressuposto básico, o nexo entre saúde psíquica e trabalho, porém se continua testando tal nexo como hipótese. Assim, esse nexo é pressuposto e hipótese de pesquisa ao mesmo tempo (Borges et al., 2007). A necessidade de comprovar a validade de tal hipótese, provavelmente, segue forte nas pesquisas como uma reação à realidade de que, na Psicologia tradicional, há a tendência de separar os assuntos do trabalho daqueles referentes à saúde (Lima, 1996), com certeza reflexo da tradição positivista que tende a fragmentar os objetos de estudo.

Essa tensão concretiza-se na forma de uma segunda; esta no campo das questões trabalhistas dizendo respeito às dificuldades de estabelecer o nexo causal entre doenças e alterações psíquicas apresentadas pelos indivíduos e as características de seu trabalho. O reconhecimento legal (Lei 11.430, de 26 de dezembro de 2006)* do nexo epidemiológico para fins trabalhistas tem amenizado tal tensão. A aplicação dessa lei tem contribuído, inclusive, para a articulação de níveis

* Sobre esse resgate histórico do campo do saber, o leitor pode consultar vários textos, tais como Jahoda (1987), Warr (1987), Mirowsky e Ross (1989), Codo (1993), Alvaro (1995), Canguilhem (1995), Lazarsfeld, Jahoda e Zeisel (1996), Lima (1996, 2002, 2006a, 2011), Caponi (1997), Jaffe (1995), Sato (2001, 2002), Jacques e Codo (2002), Codo, Soratto e Menezes (2004), Lima (2006a), Dejours (2007), Mendes (2007a), Guimarães, e colaboradores (2008), Bendassolli e Soboll (2011) e Borges e colaboradores (2007).

* Essa lei está disponível no site <http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/2006/11430.htm>. Reconhecer o nexo epidemiológico, de maneira simplificada, significa afirmar que se um trabalhador é acometido por um tipo de enfermidade que tecnicamente já foi considerada de alta prevalência em sua ocupação, ele não precisa provar o nexo causal entre sua doença e o trabalho que realiza.

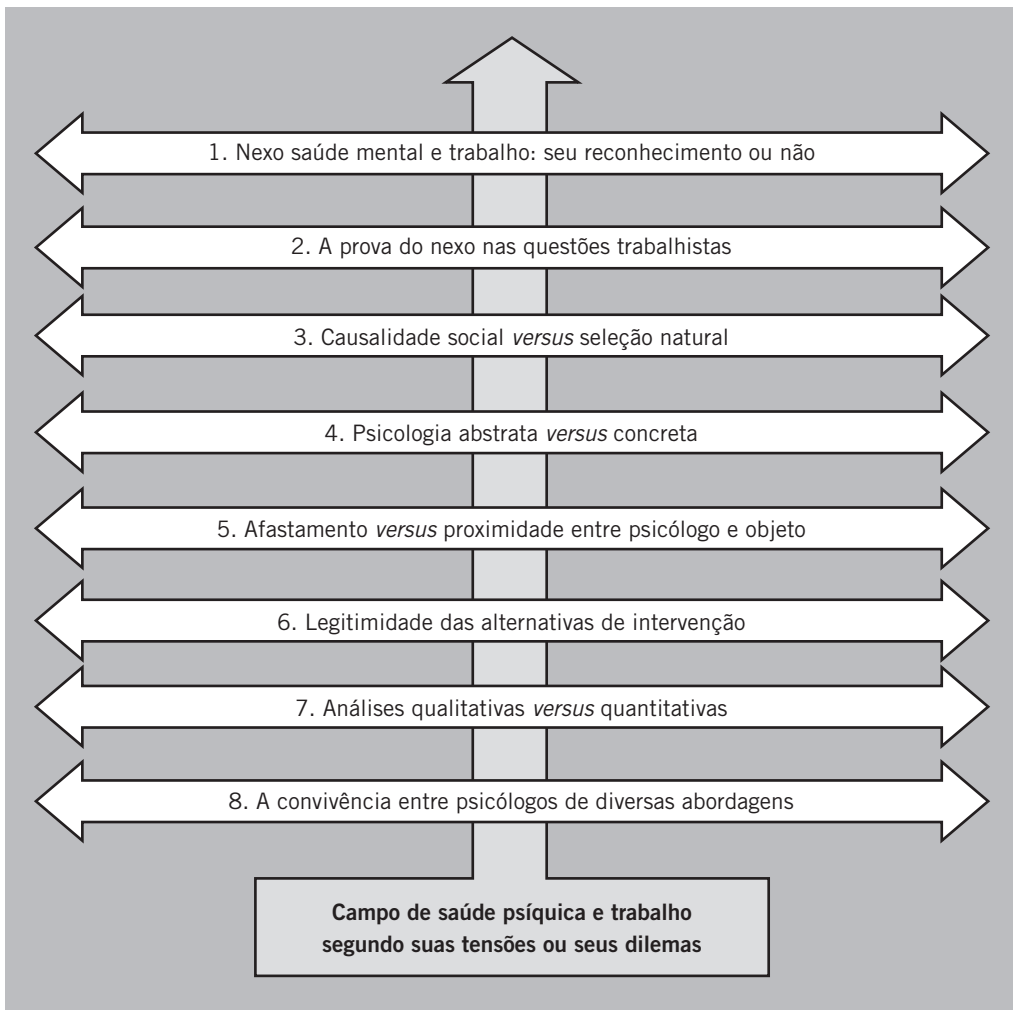


Figura 20.1 O campo de saúde psíquica e trabalho e suas tensões: uma síntese.

Fonte: As autoras.

de análises individuais (micro) e ocupacionais (macro), pois conduz à compreensão do caso individual (trabalhador reclamante) à luz do que se sabe da ocupação exercida. Entretanto, essa tensão tem estado presente nos debates acadêmicos e no cotidiano do exercício profissional. Jacques (2006), por exemplo, assinalou a existência de descrições de acidentes pelo próprio Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que busca a explicação na pessoa apesar das

evidências. Nessas circunstâncias, a culpa pelo acidente é atribuída ao próprio trabalhador em decorrência de uma análise que não foca o contexto da ocupação e/ou da organização na qual ele está inserido.

Uma terceira tensão é a discussão, muito presente nos anos de 1980, sobre os efeitos psíquicos do desemprego em relação à explicação pela causalidade social (a situação do desemprego) ou pela seleção natural (pessoas mais frágeis psiquicamente tende-

riam a perder o emprego). Mirowsky e Ross (1989) demonstraram, por intermédio de pesquisas longitudinais, que a hipótese da causalidade social da deterioração da saúde psíquica explica mais que a hipótese concorrente. Outras pesquisas (p. ex., Alvaro; Garrido, 1990; Banks et al., 1980; Borges; Argolo, 2002; Jahoda, 1987) corroboraram tais resultados, como assinalou a revisão de Garrido (1995) sobre os efeitos psicossociais do desemprego. Entretanto, no cotidiano, os psicólogos ainda se dividem em torno de tais hipóteses. A persistência dessa tensão, apesar das evidências empíricas, pode indicar que está implicada nela a visão de mundo dos profissionais como pessoas. Há uma tendência a compreender que a primeira hipótese conduz a responsabilizar as organizações e o poder público pelo adoecimento psíquico no trabalho, enquanto a segunda, a responsabilizar o próprio trabalhador.

Essa tensão observada nos estudos sobre os efeitos psíquicos do desemprego também se faz representar nos demais temas do campo da saúde psíquica e do trabalho, mantendo o dualismo entre buscar causas no ambiente (nas condições de trabalho, da conjuntura socioeconômica, etc.) ou nas características intrínsecas das pessoas. Tal tensão também abrange a polêmica sobre a responsabilização ética e política pelo processo de saúde-doença no trabalho e dificulta compreender como as histórias das pessoas interagem com os aspectos ambientais e vice-versa no decorrer do referido processo.

A busca de explicações nas características das pessoas ou no ambiente está, por sua vez, relacionada à quarta tensão, que se refere à adoção de um caminho que construa uma psicologia abstrata ou uma psicologia concreta. A diferença entre as duas psicologias remete ao pressuposto ontológico adotado pelo psicólogo, ou seja, a visão

que ele tem de acesso à realidade, que, por sua vez, define seu objeto de estudo ou de focalização: interessa ou não o trabalho concreto, aquele como de fato se realiza (Lima, 2002, 2004). A quinta tensão tem uma natureza eminentemente epistemológica, uma vez que faz referência à relação do psicólogo com seu objeto, nesse caso, o nexo entre trabalho e saúde psíquica. Até que ponto o psicólogo tem a condição de avaliador externo e até que ponto o trabalhador está envolvido na compreensão da própria situação? Tal tensão tem desdobramentos diretos nas opções metodológicas dos psicólogos (Valles, 2007), como abordamos adiante.

A sexta tensão refere-se às atuações recomendáveis ao psicólogo que age no campo: há psicólogos defendendo que a atuação deve centrar-se exclusivamente no assessoramento das políticas públicas e na fiscalização da aplicação delas, enfatizando a adoção de medidas preventivas em saúde psíquica; outros seguem defendendo a necessidade também de uma atuação dentro das organizações, inclusive para fazer valer as políticas públicas dirigidas à proteção da saúde psíquica do trabalhador e focalizar a prevenção ao cuidar diretamente das condições de trabalho. A divergência quanto à atuação em prevenção reside, portanto, na eleição do caminho de sua construção. Essa tensão existe a ponto de o Conselho Federal de Psicologia (CFP) mobilizar o Centro de Referência Técnica em Políticas Públicas (CREPOP) em relação ao assunto e ambos editarem um documento de referência intitulado *Saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública: referências para a atuação do psicólogo* (Conselho Federal de Psicologia, 2008).

A sétima tensão refere-se a aspectos metodológico-instrumentais. Trata-se de uma tensão que consiste em reproduzir nesse campo uma questão que perpassa a Psicologia Social como um todo: o uso de técnicas qualitativas ou quantitativas. Des-

de o início da década de 1990, autores que se ocupam com a reflexão epistemológica, como Katzell (1994) e Alvaro (1995), têm apontado a tendência de superação do dualismo entre técnicas quantitativas *versus* qualitativas. Fernandes (1997), por sua vez, aprofundou-se na reflexão sobre a interdependência das noções sobre qualidade e quantidade, mostrando que uma não existe sem a outra, bem como que uma modifica a outra dinamicamente. Na discussão específica de nosso campo, Lima (2002), fundamentando-se em Le Guillant, argumenta que o instrumento não define por si a adesão a um ou a outro modo de abordagem. Em contrapartida, Bendassolli e Soboll (2011) consideram importante privilegiar as chamadas técnicas qualitativas como uma estratégia para refletir sobre as práticas do sujeito no trabalho. Essa tensão, portanto, persiste em nosso meio.

Por fim, identificamos uma última tensão na esfera de convivência dos psicólogos de diversas abordagens. Embora hoje predomine um discurso em prol do respeito às diferenças de pensamento, na prática profissional, o reconhecimento de tal diversidade não é fácil, pois observamos a tendência de desqualificação da abordagem adotada pelo outro. Essas dificuldades de convivência de abordagens não são, entretanto, exclusividade do campo de saúde psíquica e trabalho, mas aqui se reproduzem os mesmos problemas existentes na Psicologia como um todo. Aliás, é interessante lembrarmos que Turato (2003), abordando a dinâmica no interior das comunidades científicas, descreve dois fenômenos peculiares: o etnocentrismo e o individualismo acadêmicos. No primeiro, um grupo de pessoas identificado por uma filiação a uma perspectiva de análise na Psicologia considera que apenas o que eles pensam ou fazem é válido. No segundo, o pesquisador centra-se somente no que ele mesmo

desenvolve, menosprezando, por exemplo, todos os estudos antecedentes, bem como as demais contribuições atuais de outros pesquisadores. Convivemos com esses fenômenos no nosso cotidiano, e todos nós, pesquisadores e/ou profissionais, em algum momento, praticamos um ou outro.

A existência de tensões pode, por um lado, adquirir o sentido de um convite desafiador a aprofundar a reflexão e a pesquisa no campo. E, sem dúvidas, esse fenômeno tem ocorrido. As tensões instigam a curiosidade humana e, provavelmente, mobilizam a busca por respostas. Assim, observamos o aumento do número de publicações no País e de psicólogos envolvidos com o campo. Por outro lado, tais tensões podem dificultar o diálogo entre pesquisadores e profissionais de diferentes abordagens, crescendo a tendência a não se perceber as limitações da abordagem de identificação e as contribuições das demais abordagens (etnocentrismo acadêmico). Não é por acaso que Jacques (2003) assinalou o crescimento do interesse pelo nexo entre trabalho e saúde/doença e, ao mesmo tempo, imprecisões teóricas e metodológicas frequentes. Com tantas tensões, não é difícil reconhecer as inseguranças do psicólogo que atua nesse campo, justificando, assim, a importância deste capítulo.

CONCEITOS BÁSICOS E FUNDAMENTAÇÃO

Para tratarmos os conceitos básicos e a fundamentação do campo, iniciamos pelos aspectos terminológicos. Estamos designando nosso capítulo de “saúde psíquica e trabalho”. É hora, então, de indagarmos: por que essa opção? A tradição principal é, sem dúvida, a expressão “saúde mental e trabalho”, que, inclusive, predomina nas publicações brasileiras. No entanto, con-

sideramos que essa expressão remete ao dualismo mente e corpo, seguindo o modelo biomédico tradicional de influência cartesiana em que o corpo é separado da mente e apenas o primeiro, por ser observável, pode ser objeto da ciência (Ogden, 1999; Stroebe; Stroebe, 1995). Tal modelo caracteriza-se também na busca de causas explicativas para a saúde e/ou a doença em fatores biológicos externos ou internos ao organismo, bem como tomar saúde e doença como estados excludentes. Evidenciando a atribuição desse sentido compartilhado culturalmente ao termo “mente”, o *Novo Dicionário Aurélio* (Ferreira, 2009, p. 1312) define mente como “Intelecto, pensamento, entendimento; alma, espírito; concepção; imaginação [...]”. Essa definição, ao menos em aparência, supõe algo separado (de forma dual) do corpo. Além disso, Traverso-Yépez (2008) argumenta que fomos socializados no pensamento cartesiano, daí nossa tendência ao raciocínio dualístico. Na realidade, a produção de conhecimento em nosso campo da Psicologia não exclui a interação entre mente e corpo, nem a expressão de problemas psíquicos no corpo e vice-versa. Assim, consideramos que a expressão “saúde psíquica” retrata melhor o que se faz no campo de saber e de atuação, pois o termo “psíquico” não é sinônimo de “mental”, uma vez que já abrange em sua concepção a noção de multicausalidade. Esperamos, portanto, que a aplicação do termo “psíquico” adjetivando a saúde funcione como um incentivo para podermos raciocinar a partir de concepções processuais, ultrapassando os limites de nossa própria socialização.

Outra expressão que vem sendo utilizada nas publicações é “saúde ocupacional”, sendo consolidada inclusive pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (Vieira, 2008). Essa expressão

remete à multidisciplinaridade e à multi-profissionalização. Diferentes profissionais de saúde atuam em saúde ocupacional (p. ex., médicos e enfermeiros, entre outros). Por isso, já se fala em uma Psicologia da Saúde Ocupacional a exemplo da European Academy of Occupational Health Psychology e da Associação Americana de Psicologia (Guimarães et al., 2008). Entretanto, quando a opção é essa, entendemos que se parte do reconhecimento de um novo campo do saber e de uma atuação na interface da Psicologia da Saúde e da Psicologia do Trabalho e das Organizações. Essa designação apresenta uma vantagem política, pois, como assinalam Guimarães e colaboradores (2008), no Brasil, a atuação do psicólogo não é legalmente exigida no âmbito da saúde ocupacional, enquanto é requerida a atuação dos enfermeiros, médicos, engenheiros e técnicos de segurança. Essa realidade contrasta com outros aspectos de avanço da legislação trabalhista brasileira, que, por exemplo, reconhece a síndrome de *burnout* como doença do trabalho. Outras designações são “saúde do trabalhador” e “saúde mental do trabalhador” (Ramming; Nardi, 2007; Sato; Lacaz; Bernardo, 2006). Ambas remetem diretamente à questão da assistência ao trabalhador, o que implica uma restrição à delimitação do tema. Nossa intenção é, entretanto, tratar do tema na interface com a Psicologia do Trabalho e das Organizações. Por isso, consideramos que a expressão “saúde psíquica e trabalho” é mais adequada para o presente capítulo.

Outra designação que vem sendo utilizada é o termo “clínicas do trabalho”. Ele, na realidade, implica um recorte um pouco distinto do campo, de modo que se excluem as abordagens individualistas, as quais serão as primeiras a serem abordadas a seguir. Bendassolli e Soboll (2011), por exemplo, fazem isso designando abor-

dagens cognitivo-comportamentais e esperando que elas centrem-se em oferecer instrumentos de controle à gestão em uma economia capitalista. Atribuem às demais abordagens que incluem a denominação de clínicas do trabalho uma intenção de emancipação dos trabalhadores. Consideramos, entretanto, que é duvidosa a avaliação dos autores, já que todos vivemos atualmente sob o modelo econômico capitalista em que as novas formas de organização do mundo do trabalho, com o uso das tecnologias de informação e comunicação, segundo Castells (2010), interpenetram as vidas de todas as pessoas. Essa compreensão do sistema capitalista permite o entendimento de que quaisquer abordagens desenvolvidas na Psicologia podem ter um poder emancipante da condição humana em alguma proporção e, ao mesmo tempo, é cooptada pelo sistema. Lembramos que o desenvolvimento do sujeito crítico e reflexivo é de interesse crescente das atuais organizações.* Além desse problema, Bendassolli e Soboll (2011) reconhecem que a expressão “clínicas do trabalho” pode confundir, remetendo à ideia de consultório. Consideramos que, por consequência, pode induzir, paradoxalmente, uma expectativa de abrangência limitada às abordagens individualistas.

Esclarecido esse aspecto terminológico, consideramos importante identificar os pontos que nos unem. O primeiro deles é a definição de nosso objeto principal: a saúde psíquica no ambiente de trabalho, em que a saúde é um processo multifacetado, abrangendo simultaneamente o adoecimento e a promoção da saúde. Apesar de identificarmos como objeto comum, reconhecemos a existência de múltiplos conceitos. Desde a influência do conceito da OMS (em 1948) – que define saúde como um estado

de bem-estar físico, psíquico e social e não só a ausência de enfermidade –, há a tendência de buscar ou construir um conceito que ofereça uma referência positiva sobre a saúde. Esse conceito, embora siga influente, tem sido criticado por vários autores, entre os quais Caponi (1997), Benavides, García e Ruiz-Frutos (2004), que sublinham seu caráter utópico e pouco dinâmico, pois tal conceito menciona um estado de plenitude e é pouco mensurável, sendo, por exemplo, pouco útil para avaliar a eficácia de políticas públicas e de saúde coletiva. Benavides, García e Ruiz-Frutos (2004, p. 3) também apontaram que a própria OMS reformulou o conceito estabelecendo como meta que: “[...] todos os cidadãos alcancem um grau de saúde que lhes permita levar uma vida social e econômica produtiva [...]”. Segundo a compreensão desses autores, tal conceito introduz a noção de equidade, incorporada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Outros autores têm atentado para critérios de autonomia para definir a saúde, para ausência de limite claro entre doença e saúde e para uma qualidade de vida que permita ao indivíduo recuperar-se a cada enfermidade (Benavides; García; Ruiz-Frutos, 2004; Caponi, 1997). Há publicações anteriores que refletem sobre tal evolução conceitual;** por isso, registramos apenas que a evolução do referido conceito básico é um dos eixos de desenvolvimento do campo, pois favoreceu a ampliação do leque de tópicos e de intervenções do psicólogo, como algumas pesquisas que passaram a construir modelos descritivos e explicativos, abrangendo indicadores positivos de bem-estar ou de saúde (p. ex., Alvaro;

* Esse aspecto é tratado neste livro nos capítulos 5, 15, 16 e 17.

** Tal evolução conceitual pode ser mais bem compreendida em textos como os de Stroebe e Stroebe (1995); Caponi (1997); Ogden (1999); Seligman e Csikszentmihalyi (2000); Bucher (2003); Benavides, García e Ruiz-Frutos (2004).

Páez, 1995; Andrade, 2008; Canguilhem, 1995; Chaves, 2007; Siqueira; Padovam, 2008; Warr, 1987); abriu-se espaço para a atenção a alterações psíquicas menores ou transtornos leves (Goldberg, 1972; 1978); e favoreceu-se uma compreensão de que mudanças nas organizações podem ser estratégias de promoção e prevenção em saúde e que, no nível organizacional, políticas de saúde podem ser adotadas (Jaffe, 1995).

Outro ponto que nos une é assumir que o trabalho tem um papel estruturante na vida cotidiana do homem contemporâneo e na própria construção da condição humana e das sociedades. Pois é esse pressuposto que sustenta outro igualmente importante para o campo: a existência de nexos entre o trabalho e a saúde psíquica. É pelo papel estruturante do trabalho na vida do indivíduo e da sociedade que suas condições (precárias ou enriquecidas) e as formas como as pessoas relacionam-se com elas estão, de um lado, envolvidas na etiologia das enfermidades e na ocorrência de certas endemias e, de outro, implicadas na produção e na valorização da condição humana e do bem-estar. Ademais, devemos considerar que os diferentes trabalhadores atribuem e constroem significações para as mesmas condições; fenômenos que medeiam o impacto das condições de trabalho na deterioração ou promoção da saúde psíquica.

Ao mesmo tempo que esses pontos nos unem no campo do saber e da atuação, os posicionamentos, ante as diferentes tensões anteriormente referidas, contribuem nos diferenciando em abordagens ou perspectivas de análises. A compreensão da extensão de tal nexo entre saúde psíquica e trabalho é um diferenciador importante das abordagens adotadas por pesquisadores e profissionais nesse campo, como veremos adiante.

Antes de adentrar na identificação das abordagens, que supõe uma ação classificatória, precisamos esclarecer os critérios

que aplicamos para diferenciá-las. O ato de classificar não é fácil, principalmente quando se trata de campo do saber com todas as tensões já mencionadas. Na literatura especializada, observamos a persistência de imprecisões na identificação/classificação das abordagens porque, geralmente, não se torna explícito o critério utilizado para diferenciar uma abordagem da outra. Assim, mesclam-se classificações de abordagens com linhas de conteúdos temáticos e com tipos de ações dos psicólogos, sem fazer qualquer alusão a eles. Defendemos que três aspectos do campo do saber – temas focalizados, ações profissionais e abordagens teóricas – entrecruzam-se como dimensões relativamente independentes (Fig. 20.2), como discutimos a seguir.

Tentar organizar o campo pelos temas de conteúdo significa diferenciar os estudos e as atuações do psicólogo pelos subtópicos utilizados para recortar a realidade, ou seja, observar que fenômeno, relativo ao nexo entre saúde psíquica e trabalho, está sendo posto em foco. Dessa forma, temos grandes temas, como efeitos do desemprego; bem-estar; subjetividade do trabalhador; estresse e síndrome de *burnout*; lesões por esforço repetitivo (LERs)/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs) e outros quadros psicossomáticos; transtornos leves e psicopatologias no trabalho.

Enquanto isso, se levarmos em conta a ação do psicólogo, vamos examinar se aqueles mesmos tópicos estão sendo abordados para fins de diagnóstico, de prevenção do adoecimento ou de assistência ao cidadão trabalhador.

Por fim, se vamos classificar estudos e atuações segundo o olhar do profissional (abordagens), estaremos, portanto, classificando de acordo os pressupostos fundamentais assumidos pelo profissional. As diferentes abordagens conduzem o psicólogo a assumir posições distintas no que se refere

às tensões que enumeramos no início do capítulo, sendo importante assinalar que três das tensões fazem referência aos critérios utilizados por autores que têm se dedicado à reflexão epistemológica (p. ex., Montero, 2000; Valles, 2007) para distinguir paradigmas, representando três pressupostos fundamentais: ontológico, epistemológico e metodológico (tensões 4, 5 e 6, respectivamente). A partir da diferenciação por esses três pressupostos, agrupamos formas de saber e de atuação, designando abordagens.

A falta dessa distinção (entre temas, ações e perspectivas de análise do psicólogo)

pode conduzir, por exemplo, ao equívoco de identificar um tema com uma única abordagem. A partir de tal distinção, podemos imaginar o espaço tridimensional (Fig. 20.2) em que os três aspectos do campo entrecruzam-se. Agrupamos as abordagens em três grupos: as individualistas, a psicodinâmica e as psicossociológicas. Dentro dessas abordagens, ainda são identificadas diferenças de perspectivas de análise especialmente entre as abordagens psicossociológicas. Mas, considerando apenas as três abordagens, a Figura 20.2 simboliza esquematicamente o cruzamento entre os três critérios. Nosso

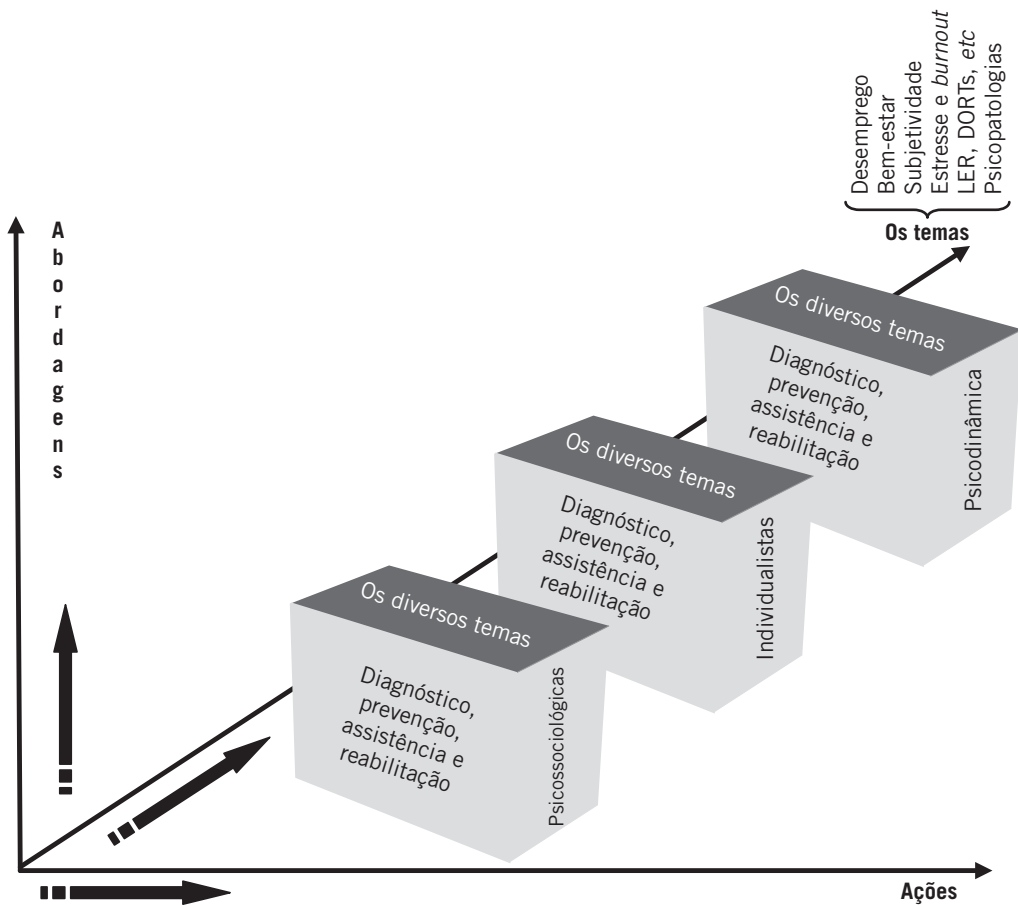


Figura 20.2 O cruzamento de temas, ações e abordagens do psicólogo.

LER: Lesões por esforços repetitivos; DORTs: Distúrbios osteonucleares relacionados ao trabalho.

Fonte: As autoras.

esquema pode induzir, no entanto, à compreensão de total independência entre os referidos aspectos, o que é incorreto da mesma maneira que é equivocado identificar um tema a uma abordagem. Há temas que são mais desenvolvidos em uma abordagem do que em outra, mas há sempre uma possibilidade de nova situação.

Passaremos, então, a descrever as três abordagens, mas sem antes deixar de sublinhar que estaremos apresentando uma síntese didática. Sintetizar implica sempre deixar lacunas e correr o risco de cometer novas imprecisões. Mas esse é um caminho para seguir construindo e reconstruindo nossos conhecimentos. Portanto, esperamos que o leitor esteja ciente de que este capítulo não o dispensa de buscar literaturas que aprofundem cada uma das três abordagens. Aqui, descreveremos essas abordagens apenas nos pontos que as diferenciam, sendo suficiente para atingir o objetivo do capítulo.

Abordagens individualistas

Começamos indagando: o que estamos chamando de abordagens individualistas? Um primeiro equívoco a pensar é que seriam abordagens mais preocupadas com as pessoas individualmente. Todas as abordagens, na realidade, focam a pessoa. A diferença está na forma em que buscam explicar o processo de saúde/doença no ambiente de trabalho. As abordagens individualistas caracterizam-se por buscar explicações mais nas características das próprias pessoas do que na relação delas com o trabalho e suas condições. Seus adeptos tendem a referir-se aos aspectos do ambiente do trabalho e das organizações apenas como pano de fundo dos fenômenos que examinam. Portanto, mesmo que haja reconhecimento do nexa entre saúde psíquica e trabalho, nessas abordagens ele é mais

enfraquecido. A subjetividade é considerada na forma de crenças, percepções, atitudes, motivações, estereótipos, preconceitos, entre outras, e no impacto que tais cognições e afetos estão relacionados e/ou imbricados no processo de saúde/doença. No entanto, o trabalho aparece como categoria social secundarizada tanto na construção de tais cognições quanto na etiologia do processo de saúde/doença.

Tal posicionamento quanto à primeira tensão está relacionado de modo direto a opinião dos psicólogos sobre tal abordagem quanto à quarta tensão, apontando na direção que tende mais à aproximação de uma psicologia abstrata, que busca explicar o processo de saúde-doença prioritariamente com base em processos psíquicos. Vejamos, por exemplo, que quando Lipp (1999) indaga sobre as origens do estresse ou sobre os estressores, classifica esses em externos e internos, no entanto, mais adiante afirma em seu texto:

As fontes internas referem-se ao que chamo de nossa 'fábrica' particular de estresse, ao nosso modo de ser, às nossas crenças e aos nossos valores, nossa forma de agir. O presente livro foi elaborado para tratar as fontes internas mais comuns e mais graves também. Os estressores externos são mais fáceis de serem identificados porque são passíveis de inspeção objetiva de qualquer um. (Lipp, 1999, p. 18)

A afirmação da autora que, ao mesmo tempo, identifica nas cognições e nos afetos as principais fontes do estresse também demonstra subestimar os estressores externos, tomando-os como fáceis de reconhecer. Compreendemos que tais estressores estão inscritos nas relações sociais complexas (inclusive nas relações de poder) da sociedade como um todo e do mundo do trabalho. Nas duas últimas décadas, pesquisas so-

bre fatores psicossociais de risco (FPR) no ambiente de trabalho têm produzido um corpo de investigação empírica e teórica (Theorell; Karasek, 1996) que não pode ser desconsiderado. Entretanto, a complexidade da origem dos FPR e as particularidades dos contextos têm revelado dificuldades consideráveis para a especificação, o diagnóstico, a prevenção e a intervenção.

A tendência a uma psicologia abstrata desdobra-se também nas alternativas de atuação que a abordagem considera legítimas e eficazes. Assim, ela afirma:

O tratamento que abordamos [...] se baseia no que designamos de quatro pilares do controle do *stress*: (1) alimentação, a fim de repor os nutrientes perdidos durante o período de *stress*; (2) relaxamento, a fim de reduzir a tensão mental e física que sempre acompanha o estressado; (3) exercícios físicos, porque o *stress* naturalmente prepara o corpo para a ação e os exercícios ajudam a eliminar a prontidão exagerada pelo *stress*; e (4) reestruturação de aspectos emocionais que se refere a conhecer a si mesmo e a mudar o modo estressante de pensar, sentir e agir. (Lipp, 2002, p. 18)

Na mesma linha, Tricoli (2002) lista uma série de recomendações para o manejo do estresse, e todas essas recomendações são de natureza cognitivo-comportamental, tais como oferecer instruções claras, usar palavras elogiosas, respeitar a individualidade, entre outras. Afirmarções como essas que citamos fazem psicólogos do campo da saúde psíquica e do trabalho indagarem se realmente a abordagem individualista constitui uma abordagem no referido campo. No entanto, se partimos dos escritos de Lipp, a resposta será afirmativa, pois ela é organizadora também (entre outras publicações suas) do livro *O stress do professor*

(Lipp, 2002), no qual se encontra o texto de Tricoli já citado.

No tocante à tensão relativa às questões trabalhistas, não conhecemos atuações de psicólogos de abordagem individualista. Entretanto, a crítica que se faz é que, quando aplicada tal abordagem, os trabalhadores tendem a ser culpabilizados pelo adoecimento e as organizações isentadas das suas omissões em lidar com as condições e a gestão do trabalho. O Estado, responsabilizado ou não, termina assumindo o ônus dos processos de adoecimento do trabalhador quando a assistência é oferecida pelo SUS. Da mesma forma, as publicações dessa abordagem não costumam fazer menção explícita acerca do impacto da promoção à saúde sobre o desempenho e vice-versa. É, entretanto, pertinente compreender que tal omissão é previsível, pois a localização das fontes de saúde apenas nos próprios indivíduos pode ser a expressão de assumir que ser saudável é um requisito para trabalhar em conformidade com a tese da seleção natural, que citamos anteriormente.

Psicodinâmica do trabalho

A abordagem psicodinâmica tem em Dejours (pesquisador/autor francês) seu principal expoente. Essa abordagem influencia os psicólogos brasileiros desde a publicação em português do livro *A loucura do trabalho* (Dejours, 1987), que teve o mérito de contribuir para disseminar a discussão sobre saúde psíquica e trabalho no Brasil (Lima, 2002, 2011). Dejours traçou uma trajetória de desenvolvimento de sua abordagem a partir da psicopatologia do trabalho, preferindo essa nova forma de designação – psicodinâmica do trabalho – pela intenção de focar a saúde e as estratégias que os trabalhadores empregam na manutenção da saúde, e também

porque ele compreendeu que o trabalho tem apenas um papel desencadeador dos processos de adoecimento psíquico. Assim, tal mudança terminológica está relacionada ao enfraquecimento da consideração do nexo trabalho e saúde/doença.

É uma abordagem com influência psicanalítica e tende a incentivar os psicólogos a assumirem uma posição ontológica idealista, em que não importa o acesso à realidade vivida, o trabalho concreto, mas o discurso do trabalhador (Lima, 2002). Em outras palavras, tende mais a uma psicologia abstrata do que concreta; fenômeno que se manifesta na busca de explicações do processo saúde-doença no trabalho a partir de aspectos intrapsíquicos, por meio de uso recorrente de conceitos psicanalíticos como mecanismos de defesa, sublimação, pulsões, entre outros. Tal posição persiste, haja vista o reconhecimento de que a clínica do trabalho adota como método fundamental a escuta e a interpretação da fala (Mendes, 2007b; 2007c), além da recorrência aos conceitos psicanalistas, como comentamos.

Mendes (2007a) descreve, entretanto, a evolução da psicodinâmica, sublinhando que, em uma segunda fase (meados dos anos de 1990), quando se consolida essa passagem da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho, o foco é posto nas

[...] vivências de prazer-sofrimento como dialéticas e inerentes a todo o contexto de trabalho, bem como estratégias usadas pelos trabalhadores para confrontar a organização do trabalho, para manter a saúde, evitar o adoecimento e assegurar a produtividade. (Mendes, 2007c, p. 35)

Na terceira fase (do final da década de 1990 aos dias atuais), é o momento da consolidação

[...] como abordagem científica capaz de explicar os efeitos do trabalho

sobre os processos de subjetivação, as patologias sociopsíquicas e a saúde do trabalhador. (Mendes, 2007a, p. 35)

Nessa afirmação da citada autora, bem como na classificação das patologias em crescente frequência na atualidade pelo próprio Dejours (2007), fica claro que tal abordagem tem admitido que certas enfermidades e alterações sejam específicas do mundo do trabalho. Dejours (2007) também localiza recentemente a etiologia das relações entre subjetividade e trabalho na organização dele e a define na

forma como, por um lado, as tarefas são definidas, divididas e distribuídas entre os trabalhadores; por outro lado, a forma como são concebidas as prescrições; e finalmente como se operam a fiscalização, o controle, a ordem, a direção e a hierarquia. (Dejours, 2007, p. 21)

Essa forma de abordar revela a evolução da psicodinâmica, aproximando-se mais de uma psicologia concreta e afastando-se de uma posição claramente idealista; fato que faz Mendes (2007a) compreender essa terceira fase como uma caminhada da psicodinâmica para a psicopatologia do trabalho. Em contrapartida, consideramos que esse processo ainda é parcial, uma vez que incorpora do mundo concreto do trabalho apenas a importância da organização do trabalho na etiologia do processo saúde-doença, deixando ao lado, segundo Mendes (2007), aspectos das condições de trabalho, como o ambiente físico, químico, biológico, as condições de higiene, de segurança e as características antropométricas do posto de trabalho. Consideramos que as condições de trabalho atualmente são definidas de modo mais amplo, abarcando não só a organização do trabalho como definida por Dejours e os aspectos notados por Mendes, mas também fatores relativos ao tipo

de contratação, de vínculo empregatício e de locais de trabalho (às vezes virtuais e/ou a distância); à minimização da separação entre as esferas domésticas e do trabalho; às novas noções de tempo e espaço; às condições de regulação das relações de trabalho e à mediação do Estado; às possibilidades de negociação, à liberdade de organização trabalhista/sindical, entre outras.* Mais importante ainda, na fase atual, é observarmos que vários outros conceitos – como mobilização subjetiva e ressignificação do sofrimento – ganharam centralidade (Mendes, 2007a). Eles são importantes na compreensão da busca da saúde do trabalhador. O primeiro é o processo de engajamento em que o trabalhador utiliza sua subjetividade e sua inteligência prática e do coletivo para transformar as situações que causam sofrimento. Implica a ressignificação do sofrimento e não a sua negação ou minimização. Tais conceitos, adicionados ao que já comentamos sobre o princípio metodológico fundamental, mostram que, na hora de intervir, é dos próprios trabalhadores, de suas cognições e elaborações pessoais que a psicodinâmica exige prioritariamente mudança. Termina, portanto, focando a explicação da saúde psíquica nos processos psíquicos pessoais. Daí, segue com uma tendência psicologizante e, em certa medida, individualista, além de idealista. O fato é que a abordagem segue apresentando dificuldades em considerar as múltiplas determinações do referido nexos, porque sua base teórica, sendo a psicanálise, tende a se prender mais às causas do próprio psiquismo e/ou do organismo (Borges et al., 2007). Como uma psicologia mais abstrata do que concreta, estimula o psicólogo a ir ao cam-

po empírico para buscar evidências que estejam em conformidade com seu corpo teórico, previamente construído. Todos esses aspectos relativos ao caráter de uma psicologia abstrata ficam bastante evidenciados nas conclusões de publicações, como:

A busca do sofrimento de Maria, evidenciando processos intra e intersubjetivos presentes na relação do sujeito com o trabalho, permite, certamente, (re)pensar o papel do trabalho nos processos de subjetivação contemporâneos. Maria relata, como experiência, o que Dejours concebeu teoricamente sobre o uso de estratégias coletivas de defesa, mobilizadas na luta contra o sofrimento no trabalho (...). Em Maria, a construção de saber é fruto de uma ligação estreita e íntima entre inconsciente e consciência, que acaba por se revelar instrumento de um transcompromisso pessoal e ético com suas produções psíquicas [...]. (Martins, 2007, p. 71-74)

Os carteiros enfrentam o sofrimento no trabalho por meio das estratégias defensivas de negação, compensação e racionalização, para se adequarem às exigências da organização prescrita e buscar o prazer e, de certa forma, garantir a saúde no trabalho. (Rossi; Caldas; Melo, 2007, p. 341)

Essas características já assinaladas implicam também dificuldades em fazer frente à tensão referente às questões trabalhistas, porque, privilegiando um subjetivismo idealista, as técnicas que utilizam predominantemente (p. ex., análise do discurso) são frágeis para apreender aspectos que atingem uma ocupação e/ou uma organização como um todo. Perdem a capacidade de transitar do particular ao geral e vice-versa, movimento comumente reclamado de uma visão de mundo dialética. Esse fato fica evidenciado no trecho do texto de Martins (2007) supracitado.

* Sobre o tema das condições de trabalho na atualidade, recomenda-se consultar os seguintes autores: Ramos, Peiró e Ripoll (2002), Blanch (2003) e Alvaro (2006).

Um caminho na tentativa de superar limites que alguns adeptos da psicodinâmica têm adotado é o diálogo com outras perspectivas, por meio da complementaridade. É o que foi recomendado por Mendes, Ferreira e Cruz (2007) ao descreverem como estabelecer um diálogo entre a psicodinâmica do trabalho, a ergonomia e a psicomетria. Os referidos autores concluem de suas exposições que:

[...] contribuições da ergonomia da atividade e da psicomетria enriquecem, ampliam e permitem desvelar, de modo mais completo e integrado, os processos de subjetivação originados na organização do trabalho. Aproximam o pesquisador da realidade, traduzindo as vivências de prazer-sofrimento, as estratégias de mediação e o processo saúde-adoecimento de maneira mais inteligível, acessando, ao mesmo tempo, a amplitude e a especificidade do fenômeno [...]. (Mendes; Ferreira; Cruz, 2007, p. 108)

Em Sznелwar (2007), a noção de complementaridade evidencia-se no trecho:

Enquanto a ergonomia propõe-se a transformar o trabalho, com o envolvimento do trabalhador, a ação transformadora proposta pela psicodinâmica do trabalho está voltada para o reforço ou a reapropriação do sentido de trabalhar pelos trabalhadores, favorecendo uma transformação individual e do coletivo com uma perspectiva de ações efetivas no mundo do trabalho. (Sznелwar, 2007, p. 48)

Essas análises de Mendes, Ferreira e Cruz (2007) e Sznелwar (2007) apontam tanto para a direção de uma recuperação dialética quanto para a tentativa de construção de uma psicologia concreta. Da mesma maneira, as conclusões de textos de alguns autores, apresentando resultados de

pesquisas empíricas, revelam a persistência de uma psicologia abstrata. Aqueles autores, que trilham o caminho que citamos, concluem seus textos exprimindo a aproximação de uma psicologia concreta:

O estudo contribui para dar visibilidade e incentivar a discussão sobre o sofrimento vivenciado pela categoria bancária, associado a uma história recente de grandes transformações das condições e da organização do trabalho. O estudo aponta ainda a reflexão a ser feita sobre a relação saúde e trabalho e a importância das práticas de gestão que devem favorecer a construção e o desenvolvimento de políticas de saúde e qualidade de vida no trabalho, como estratégia para minimizar o sofrimento e o adoecimento. (Sousa et al., 2007, p. 357)

Pode-se concluir que o contexto de produção desta empresa não é totalmente favorável para seus trabalhadores. Apesar de existirem estruturas e suporte para exercer a tarefa, esta se torna desprazerosa pelo forte exercício da rigidez existente na organização. Os frutos colhidos com isso são a falta de reconhecimento, o esgotamento emocional, o desgaste, a insatisfação. Atitudes individualistas e sentimentos de desconfiança tornam o clima da empresa desagradável para o exercício da tarefa. (Rego et al., 2007, p. 321)

Assim, sobre a abordagem da psicodinâmica do trabalho, sublinha-se que as aplicações e os desenvolvimentos da psicodinâmica não são homogêneos, por consequência, suas limitações e seus pontos fortes variam com a diversidade de suas aplicações.

Abordagens psicossociológicas

As abordagens psicossociológicas na Psicologia Social são descritas por vários autores

(p. ex., Alvaro, 1995; Alvaro et al., 2007; Montero, 2000; Prado, 2002; Sandoval, 2000), cujos textos recomendamos para aprofundar o assunto. Chamamos a atenção para o fato de estarmos, neste capítulo, referindo-nos às abordagens psicossociológicas sempre no plural propositadamente. Isso porque compreendemos que elas são, na realidade, um conjunto e uma dispersão de várias perspectivas de análise sutilmente diferentes umas das outras (Amado; Enriquez, 2011; Carreteiro; Barros, 2011). Compete-nos, então, indagar: o que há de comum em tais perspectivas que nos conduziram a reuni-las sob o título “abordagens psicossociológicas”? Que pressupostos básicos partilham? Como tais perspectivas concretizam-se no campo da saúde psíquica e trabalho? O primeiro ponto é que, nessas abordagens, assume-se abertamente a categoria trabalho como estruturante tanto do ponto de vista das sociedades como da vida concreta dos grupos e das pessoas. Desse ponto fundamental, parte o posicionamento dos psicólogos que aplicam essas abordagens em referência a cada tensão comentada na introdução do capítulo. Assim, a posição dos psicólogos sobre o nexo entre saúde psíquica e trabalho abrange a consideração do papel do trabalho no desenvolvimento de identidade (Chanlat, 2011). Dessa forma, trabalhar e desempenhar-se bem são fontes de promoção de saúde, de construção de identidade e de inserção social entre aspectos da vida humana. Entretanto, as condições em que realizamos o nosso trabalho (abarcando tanto as características de conteúdo e organização do trabalho quanto os aspectos ambientais que circundam o trabalho em níveis de análise do micro ao macro) podem nos levar à promoção da saúde e/ou ao adoecimento. É, por isso, que nessa abordagem há a busca da explicação do processo saúde/adoecimento diretamente nas condições de trabalho.

Diferentemente das abordagens anteriores, nela, o trabalho concreto é o foco principal. As características pessoais (humanas) são consideradas, mas ora como elementos facilitadores do processo, ora como elementos mediadores da relação da pessoa com o mundo do trabalho. Por isso, faz sentido reafirmar uma psicopatologia do trabalho (Borges et al., 2007; Codo, 1993; Heloani, 2008; Jahoda, 1987; Kohn; Cooler, 1983; Lima, 2002; 2004).

Uma das consequências desse posicionamento sobre a primeira tensão é que parte dos psicólogos dessa abordagem tem adotado uma perspectiva epidemiológica, porque ela permite focar níveis de análises, como as ocupações, as organizações, o mundo do trabalho e a sociedade em geral e/ou determinados contextos históricos de uma sociedade. Esse caminho exige domínios de vários dos tópicos identificados anteriormente e a aplicação de um olhar que permita buscar as variações deles por ocupações, por organizações ou por determinados períodos conjunturais e históricos. Tal caminho ajuda que os psicólogos apoiem-se no nexo epidemiológico quando se referem às questões trabalhistas. E, por consequência, assumam uma ética, em que, respeitando a humanidade na sua diversidade psíquica e social, mais faz sentido pensar em replanejar o trabalho em sua forma de organização, condições e gestão, adequando melhor o mundo do trabalho às diferentes pessoas, do que o contrário.

Portanto, em referência à terceira tensão, os psicólogos quando aplicam as abordagens psicossociológicas posicionam-se fortalecendo a explicação da causalidade social. A busca, entretanto, da causalidade social não é simples. Exige domínio de conhecimentos interdisciplinares referentes a diversos níveis de análise, fazendo com que os psicossociólogos do trabalho assumam outra tendência da abordagem oriunda da

Psicologia Social: adotar análises multiníveis (Alvaro et al., 2007; Katzell, 1994). Tal característica da abordagem termina por incentivar a atuação em equipes multiprofissionais, promovendo a apreensão dos diversos níveis de análise (micro, meso e macro) e sua articulação.

Isso, por sua vez, implica o investimento na construção de uma psicologia concreta (quarta tensão) em que a subjetividade humana tem lugar de elaboração na concretude do mundo do trabalho que o próprio homem vem criando e recriando (Lima, 2002). Essa forma de se posicionar diante da quarta tensão é coerente, ao mesmo tempo, com as novas perspectivas de análise das organizações que as olham como processuais, dinâmicas e passíveis de serem construídas, desconstruídas e reconstruídas por seus participantes (Bastos et al., 2004) e com uma perspectiva construtivista da Psicologia Social (Alvaro, 1995; Alvaro et al., 2007; Carvalho; Borges; Rego, 2010).

O compromisso dessas abordagens com a construção de uma psicologia concreta também implica a emergência de outra característica comum: o compromisso com uma atuação e uma construção teórica transformadora em que o saber científico incorpora-se no social e o modifica. Em outras palavras, compreende que a construção do saber é práxis social (Ibañez; Iñiguez, 1996). Esse modo de posicionar-se também implica aproximação e envolvimento do psicólogo com seu objeto (pressuposto epistemológico). Para esclarecer o que isso significa concretamente, podemos exemplificar com o caso de pesquisas realizadas sob solicitação de instituições, impactando sobre as condições de trabalho, tais como aquelas que deram origem aos livros *Trabalho: educação e carinho* (Codo, 1999) e *Aspectos psicossociais dos petroleiros* (Borges; Barbosa, 2006). Esses dois livros resultaram da reflexão de pesquisas epidemiológicas que, ao mesmo tempo,

eram diagnósticos ocupacionais solicitados, um, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação (CNTE) e, outro, pelo Sindipetro do Rio Grande do Norte (RN). O primeiro desvelou a endemia de síndrome de *burnout* em educadores de escolas públicas do ensino fundamental e médio no Brasil. O segundo descreveu os transtornos leves e agravos na vida familiar de petroleiros, vivenciados em decorrência de regime de trabalho adotado, e a relação que tais transtornos tinham com valores organizacionais e com a satisfação no trabalho. Os resultados desse diagnóstico foram usados como um dos fundamentos das negociações trabalhistas que resultaram na extinção desse regime de trabalho.

Outros diagnósticos/pesquisas ocupacionais, mesmo sem partirem da solicitação dos participantes da pesquisa, também têm uma inserção social tão evidente que rapidamente seus conteúdos são absorvidos em outras práticas sociais. É o caso, por exemplo, de pesquisa realizada com ex-bancários de um banco de economia mista que foi liquidado no Rio Grande do Norte (Borges; Maranhão, 2006), cujo relatório de pesquisa foi incorporado em processos trabalhistas sob solicitação judicial e também serviu de fundamento para a apresentação de projeto de lei estadual, regulando a incorporação e o enquadramento de parte de tais ex-bancários nos quadros estaduais de pessoal.

Sato, Lacaz e Bernardo (2006), por sua vez, relatam como exemplo uma atividade desenvolvida por psicólogos e psiquiatras, no contexto da saúde pública paulista, que consistiu em uma avaliação neuropsicológica que identificou a intoxicação por mercúrio metálico com suas manifestações somáticas e psíquicas. Essa atividade, além da assistência individualizada, gerou resultados como a definição de critérios para afastamento da exposição e o tratamento dos

trabalhadores, propostas de mudanças no ambiente de trabalho e quesitos para aposentadoria por invalidez. Em seguida, os resultados também se desdobraram na edição de norma do Ministério da Previdência Social, incluindo critérios de diagnóstico, de tratamento, de alta e de aposentadoria por invalidez.

Esses exemplos mostram que a inserção das práticas dos psicólogos no contexto social tem mais a ver com o pressuposto epistemológico assumido de proximidade e envolvimento com o objeto, com a compreensão do processo de teorizar como prática social e com a busca das determinações sociais dos fenômenos psíquicos do que com os diversos quadros teóricos, métodos e técnicas adotados.

Nessas abordagens, são marcantes as tentativas de articular diversos níveis de análise, discutindo como os aspectos da macroestrutura engendram vivências subjetivas dos indivíduos e o quanto as pessoas, agindo coletivamente, constroem e reconstroem a realidade macrosocial. Carreteiro e Barros (2011), por exemplo, argumentam que o trabalho como objeto da psicossociologia é sempre o trabalho em contexto. Essa afirmação pode remeter tanto aos aspectos macrosociais quanto aos contextos organizacionais, como é o caso do estudo de Chanlat (2011), que mostrou as possíveis aplicações do conhecimento da relação da pessoa com seu trabalho na gestão organizacional, ou, do de Amado e Enriquez (2011), que assinalaram que o contexto organizacional na contemporaneidade contribui para a construção da imagem que temos de nós mesmos.

Esse traço da abordagem de tentar articular vários níveis de análise pode ser mais facilmente observado no contexto de exemplos de pesquisas/diagnósticos já citados, porque neles o ponto de partida era a ocupação. Tanto no processo reflexivo de teorizar

quanto na incorporação dos seus resultados nas práticas sociais havia um movimento do geral para o particular, pois ocorreram mudanças concretas nas condições gerais de trabalho das ocupações e também na vida dos trabalhadores considerados individualmente. A estratégia da análise multinível, entretanto, pode acontecer quando o ponto de partida é o caso do trabalhador individual que precisa de assistência em saúde. Sato, Lacaz e Bernardo (2006), por exemplo, descrevem o processo histórico de surgimento dos centros de referência em saúde do trabalhador em São Paulo, em que o trabalhador que vive um agravo em sua saúde é acolhido em sua singularidade, mas sua queixa é compreendida no contexto da ocupação em que está inserido (i.e., no contexto social de inserção). Os casos individuais são registrados com finalidades epidemiológicas. Por isso, os autores designam a perspectiva de análise como clínico-epidemiológicas. Os psicólogos atuam inseridos em equipes multiprofissionais, facilitando o manejo de certos agravos de saúde.

A diversidade de perspectivas dentro da abordagem psicossociológica tem uma de suas fontes nos diferentes quadros teóricos utilizados, como a cognição social, o modelo ecológico de saúde de Warr (1987), a ergonomia, a clínica da atividade (Clot, 2006; Lima, 2007; Sato, 2006), o interacionismo simbólico, o construtivismo social, a psicopatologia do trabalho de Le Guillant, a saúde coletiva e a psicossociologia francesa, entre outros, além do corpo teórico desenvolvido sobre os grandes tópicos mencionados anteriormente.

Assim, vários temas que inicialmente ocupavam os psicólogos sob uma abordagem individualista passaram a ser tratados em uma abordagem psicossociológica. É o caso da síndrome de *burnout*, por exemplo. Sobre esse tópico, vários autores (p. ex., Gil-Monte, 2005; Gil-Monte; Peiró, 1997;

Tamayo; Tróccoli, 2002) têm resgatado que as suas primeiras abordagens (Freudenberger, 1974) descreviam o fenômeno como se decorresse de características individuais. A partir da influência de Maslach (1976), vem crescendo, entretanto, a tendência de explicar o fenômeno por outros níveis de análises, como organizacionais e conjunturais. Várias publicações retratam tal tendência (p. ex., Borges et al., 2002; Codo, 1999; Gil-Monte, 2005; Gil-Monte; Maslach; Schaufeli; Leiter, 2001; Jacques et al., 2010; Peiró, 1997; Tamayo; Tróccoli, 2002).

O mesmo ocorreu com os estudos sobre estresse ocupacional, o qual passou a ser compreendido em perspectivas psicossociológicas, que o descreve em seus aspectos processuais e multideterminado, mas atribuem uma maior ênfase aos fatores sociais. Guimarães e Freire (2004) revisaram os estudos sobre o estresse e apontaram essa tendência em dois modelos explicativos. O primeiro, denominado demanda-controle (D/C), toma como premissa que a combinação de duas dimensões – (1) a quantidade e o tipo de demanda; e (2) o controle sobre as tarefas no marco da divisão do trabalho – constitui-se nas principais fontes estressoras. O segundo, designado crise de gratificação, fundamenta-se na noção de reciprocidade social, de modo que entende que o estresse se origina na desproporcionalidade entre o esforço do trabalhador e as gratificações que lhe são concedidas, sendo elas o salário e os benefícios, a estima e a valorização no trabalho, e a promoção e a segurança no emprego. Martins e Guimarães (2004), por sua vez, comentam que:

[...] o modelo D/C dá uma ênfase maior na interação entre demanda e controle como possível causadora de estresse do que nas percepções individuais do trabalhador, como nos modelos que abordam o ajus-

te pessoa-ambiente (Schnall, 1998). (Martins; Guimarães, 2004, p. 58-59)

Zanelli (2010), discorrendo sobre os antecedentes do estresse, refere-se a vários aspectos do âmbito grupal e organizacional, incluindo a cultura organizacional, o estilo de gestão, as relações de poder, o suporte social provido pelo grupo de inserção do trabalhador, entre outros, sem esquecer, no entanto, os aspectos individuais.

Um ponto em que se pode estabelecer o diálogo com abordagens individualistas é quando se observa uma tendência a recuperar a ênfase em aspectos de personalidade. Essa tendência Katzell (1994) já havia assinalado. Na literatura especializada brasileira, no campo de saúde psíquica e trabalho, tal tendência é observada, por exemplo, nas coletâneas organizadas por Guimarães e Grubits (1999, 2004a, 2004b, 2008), em que surgem capítulos dedicados a temas como autoconceito, resiliência, habilidades sociais, entre outros. Essa recuperação de aspectos de personalidade pode estabelecer um diálogo com a abordagem individualista, conforme se referem a aspectos de um nível de análise microsocial. Por um lado, apresentam uma novidade que se direciona ao tratamento psicossociológico desses construtos, tomando-os como processos e construções psicossociais e sendo considerados, no campo da saúde psíquica, como elementos da história de vida das pessoas que facilitam a promoção da saúde ou adoecimento diante dos problemas inerentes à organização, às condições e à gestão do trabalho.

Por outro lado, com a recuperação de conteúdos referentes à personalidade, também tem havido uma maior recorrência a construtos mais sociais, culturalistas e políticos para a apreensão do ambiente de trabalho nas explicações do processo de saúde-doença no trabalho. Exemplos

são as análises desenvolvidas por Ferreira e Assmar (2004a, 2004b) sobre a articulação entre os construtos de cultura das organizações, justiça e satisfação no trabalho e saúde no trabalho; Ferreira (2004) sobre o bem-estar decorrente do equilíbrio entre a cultura do trabalho prescrito e a cultura do trabalho real; e Paz (2004) sobre poder e saúde nas organizações.

Em toda essa síntese sobre as grandes tensões e como elas representam-se em cada abordagem do campo, fica claro que há diferenças e semelhanças entre as três abordagens. Por isso, defende-se que é possível existir algum diálogo que permita uma convivência saudável e produtora de novos saberes. Tal diálogo requer, entretanto, prudência, como tem alertado Fielding e Schreier (2004), principalmente se tais diferenças partem dos pressupostos básicos. O respeito pela produção do outro é uma atitude profissional saudável, que permite reconhecer méritos e limitações de cada abordagem. Voltamos, então, a assinalar que há algum tempo surgem iniciativas que indicam a construção de tal diálogo. Exemplos foram citados quando discorremos sobre a abordagem psicodinâmica, e, certamente, vale a pena citar os livros *Trabalho em transição, saúde em risco* (Mendes; Borges; Ferreira, 2002), *Trabalho e saúde* (Mendes, 2008) e *Clínicas do trabalho* (Bendassolli; Soboll, 2011), os quais são coletâneas organizadas que reuniram autores de diversas abordagens.

O reconhecimento de méritos e limitações torna-se mais profundo ao dirigirmos nosso olhar para os modos de agir do psicólogo no campo da saúde psíquica e trabalho. É hora, então, de nos perguntarmos sobre os modos de ação do psicólogo que decorrem de cada uma das abordagens, concretizando funções de diagnóstico, prevenção, assistência e reabilitação. Podemos,

assim, nos indagar: a que estratégias metodológicas os psicólogos recorrem?

O AGIR DO PSICÓLOGO

Diagnóstico

Iniciamos perguntando o que significa diagnosticar neste campo da saúde psíquica do trabalhador. Diagnóstico de saúde psíquica, de maneira geral, é uma atividade investigativa complexa, pois envolve identificar o quadro nosológico de transtornos psíquicos, compreender o sofrimento do outro e avaliar uma situação de forma contextualizada e consubstanciada, refletindo sobre seu dinamismo e sua tendência de evolução (prognóstico). Quando se realiza tal atividade no campo da saúde psíquica e trabalho, essa complexidade amplia-se refletindo todas as tensões citadas como características do campo, sendo provavelmente a tensão referente à consideração do nexo entre saúde psíquica e trabalho que se manifesta de modo mais imediato.

Jacques (2007) informa que, no Brasil, tomando-se como referência a classificação de Schilling, as doenças relacionadas ao trabalho distribuem-se do seguinte modo:

1. o trabalho aparece como causa necessária;
2. o trabalho aparece como fator contributivo, mas não necessário; e
3. o trabalho é considerado um provocador de uma doença latente ou agravador de uma condição de saúde já estabelecida.

Além disso, há outras dificuldades derivadas da subjetividade do próprio trabalhador diante de sua inserção no mundo do trabalho. Um exemplo é o fato de, por

vezes, o próprio trabalhador evitar assumir sua condição de doente – talvez em função do sentimento ameaçador de perder o emprego (Minayo-Gomez; Thedim-Costa, 1997), principalmente quando o adoecer permeia a zona do psiquismo –, em que não é comum o próprio indivíduo atribuir seu sofrimento como sendo de ordem psíquica (Borsoi, 2007). Esse problema influencia, ao lado de outros aspectos sociais e técnicos, a tendência ao diagnóstico ser estabelecido quase sempre tardiamente. Aumenta, assim, a probabilidade de haver mascaramento dos transtornos psíquicos em sintomas orgânicos (Glina et al., 2001; Jacques, 2007).

Os modos de desenvolver o diagnóstico, por sua vez, representam as alternativas construídas pelos psicólogos para lidar com as tensões e as abordagens mencionadas anteriormente (Figs. 20.1 e 20.2). Certamente, o senso comum espera que as diferenças entre os modos de diagnósticos digam respeito, sobretudo, à gama de técnicas e instrumentos utilizados. Entretanto, nosso argumento é que as principais diferenças estão no modo de olhar do psicólogo para as questões de saúde psíquica e trabalho. Existe uma tendência de predomínio de certas técnicas por abordagens, mas não uma relação direta, até mesmo porque tem emergido uma tendência em defender a aplicação de estratégias que articulam mais de um método e/ou técnicas. A complexidade do diagnóstico em nosso campo tem contribuído para o acolhimento dessa estratégia. Entre outros aspectos, tal complexidade manifesta-se inclusive no reconhecimento de que pode realizar-se o diagnóstico em diferentes níveis de abrangência: no nível individual, em que se analisa o processo de saúde-adoecimento do trabalhador frente à categoria ocupacional em que está inserido; no nível organizacional, em que se investiga a prevalência de determinados transtornos psíquicos na organização como um todo,

ou por setores dela, diante do ramo de atividade em que se insere; e no nível ocupacional, em que se avalia a prevalência de certos transtornos em determinada ocupação (p. ex., bancários, profissionais de saúde, professores, etc.). Os diagnósticos individuais são importantes para subsidiar ações de assistência individualizada e de reabilitação, bem como para gerar laudos psicológicos que subsidiem decisões dos órgãos de justiça no trabalho e de previdência social. Nos dois últimos níveis de abrangência, observamos a adoção de uma perspectiva eminentemente epidemiológica. Entretanto, no primeiro nível, os subsídios da epidemiologia em saúde psíquica no trabalho são necessários como fundamentos para o estabelecimento do nexo entre saúde psíquica e trabalho. Os diagnósticos nos dois últimos níveis de abrangência são importantes para fundamentar ações de prevenção e promoção da saúde psíquica do trabalhador, o planejamento de ações assistenciais e de reabilitação, especialmente no setor público, bem como a negociação coletiva. Os diagnósticos individuais, se adequadamente registrados, podem também ter os mesmos desdobramentos mencionados em relação àqueles nos níveis organizacionais e ocupacionais. Devido a esses três níveis de abrangência, a atividade de diagnóstico tende a ser também uma atividade de pesquisa.

Há diferenças de operacionalização de diagnósticos de saúde mental e trabalho em conformidade com as abordagens adotadas pelo psicólogo. Assim, aqueles que adotam abordagens individualistas geralmente partem do diálogo com a Psicometria, sendo comum o uso de escalas e testes psicológicos. Porém, podem utilizar também técnicas que exigem análises mais interpretativas, como as entrevistas. Entretanto, não são exatamente os instrumentos utilizados que as diferenciam das demais, como já vimos, mas sim os conteúdos que são foca-

lizados nas avaliações. Nessa abordagem, o psicólogo volta-se para os aspectos cognitivos e afetivos do trabalhador. Portanto, a abordagem será determinante na definição do que será avaliado.

Para ilustrar esse tipo de diagnóstico, exemplificamos com a recente pesquisa de Rossetti e colaboradores (2008) sobre o diagnóstico do estresse em uma categoria ocupacional. A partir da definição tradicional do que seja estresse (reação do organismo junto a fatores psicológicos, físicos, mentais e hormonais diante de uma necessidade de adaptação), a pesquisa teve como objetivo realizar uma análise descritiva dos níveis de estresse no ambiente de trabalho e a manifestação da sintomatologia em uma amostra de 250 servidores públicos da Polícia Federal, com idade variando de 20 a 64 anos, com predomínio do sexo masculino (74,4%). Aplicou-se o inventário de sintomas de estresse para adultos de Lipp (ISSL) e verificou-se que a maioria dos participantes permaneceu na fase da resistência. Dessa forma, evidenciou-se a importância da utilização de instrumentos, como o ISSL, que possibilitam uma avaliação diagnóstica sobre a existência de sintomas de estresse e os níveis em que se encontram.

A pesquisa seguiu o modelo de diagnóstico a partir da coleta de dados de questionários, e, nas conclusões, os autores retomaram a questão básica desse tipo de diagnóstico, que é a responsabilização do indivíduo e o controle sobre seu estado de saúde psíquica:

Destaca-se a importância de instrumentos como o ISSL, que possibilitam uma avaliação apurada sobre a existência ou não de sintomas de estresse e o conhecimento do nível e estágio deste, para que estratégias de enfrentamento sejam adotadas antes da ocorrência de somatizações, que geram sofrimento ao indivíduo

e despesas para as organizações e a sociedade. Também demonstram as possibilidades de controle sobre o estresse elevado e algumas recomendações sobre alimentação, exercícios físicos, qualidade de vida e relaxamento. (Rossetti et al., 2008, p. 117-118)

Nessa afirmação, o nexo entre saúde psíquica e trabalho desaparece. As medidas para reabilitação prendem-se ao corpo e à vida social do próprio indivíduo. No tópico anterior sobre essa abordagem, evidenciamos o enfraquecimento do nexo entre saúde psíquica e trabalho, o que dificulta, sobremaneira, o processo diagnóstico. Nesse caso, o foco, na maioria das vezes, recai na responsabilização do indivíduo sobre seu processo de adoecimento, de modo que, muitas vezes, nesse tipo de estudo, em especial quando se fala de estresse como construto bastante estudado nessas abordagens, a relação trabalho/estresse não é direta, levando em consideração a existência de variáveis que podem estar moderando tal relação (Codo; Soratto; Menezes, 2004) e também em função da priorização dos aspectos hereditários e das relações familiares na etiologia do adoecimento psíquico (Jacques, 2003). Desse modo, uma crítica comum sobre a forma de diagnosticar nessa perspectiva refere-se ao sentido dos processos paliativos e de uma visão de homem fragmentada, que perde de vista a condição social de trabalhador (Jacques, 2003; Codo; Soratto; Menezes, 2004).

Na abordagem psicodinâmica, o nexo entre saúde psíquica e trabalho é investigado, principalmente, a partir da fala do trabalhador. Nas palavras de Mendes (2007a, p. 65), essa opção estratégica de análise está expressa: “[...] privilegia a fala, particularmente a coletiva”. Uma consequência desse foco é a adoção de um método de análise interpretativo que se sustenta conceitualmente no quadro teórico em que a realidade

de está sempre posta em dúvida para que sejam buscados os aspectos subjacentes de realidades aparentes. Portanto, está sempre em busca da realidade. Sendo a fala seu instrumento privilegiado, os adeptos dessa abordagem utilizam comumente técnicas como as entrevistas individuais e coletivas, e os conteúdos dessas entrevistas são analisados, focando os núcleos e as redes de sentido.

Isso não significa, entretanto, que sejam aplicadas exclusivamente tais técnicas. Comentamos na seção anterior que alguns autores (Mendes; Ferreira; Cruz, 2007) dessa abordagem estabelecem diálogos com outras perspectivas e áreas de conhecimento e, quanto ao tema da investigação diagnóstica, fazem isso em especial com a avaliação psicológica.

Por esse caminho, adota-se mais uma vez a ênfase no indivíduo como figura, se aplicarmos a visão da *gestalt*, em que a busca da compreensão do fenômeno se encontra nos processos intrapsíquicos para só depois dirigir-se à organização do trabalho, a qual assume a função de fundo, na *diáde* figura-fundo, assim como na *diáde* indivíduo-trabalho.

De modo categórico, Dejours, Dessors e Desriaux (1993) defendem a ideia de que a saúde é algo que se tenta conquistar, cujo principal interessado é o próprio indivíduo e, pensando assim, afirmam:

Se se aceita esta visão das coisas, então se compreende melhor que a saúde não é apenas responsabilidade dos outros, de uma instituição, dos médicos ou do Estado. É, antes de mais nada, responsabilidade de todos e de cada um. É, pois, sua responsabilidade. (Dejours; Dessors; Desriaux, 1993, p. 104)

Assim, quando se relaciona o indivíduo e o trabalho, tudo o que se refere ao

sujeito a partir de sua história de vida se altera de acordo com o seu trabalho concreto e as condições em que o realiza (Codo; Soratto; Menezes, 2004). Essas alterações tanto podem ser na direção do trabalho, como um fator de deterioração, de envelhecimento e de doenças graves, quanto na direção do equilíbrio e do desenvolvimento (Dejours; Dessors; Desriaux, 1993; Delcor et al., 2004).

Para ilustrar esse tipo de diagnóstico, recorremos à pesquisa de Barros e Mendes (2001), cujo objetivo foi investigar quais as estratégias defensivas contra o sofrimento dos trabalhadores terceirizados de uma construtora em Brasília. Para o processo de diagnóstico, realizaram-se entrevistas coletivas semiestruturadas com 20 trabalhadores. Verificou-se que os trabalhadores estavam vulneráveis e inseguros diante do modelo de produção terceirizado; modelo esse que negligencia seus direitos e exige alta produtividade. Observou-se, portanto, a existência de sofrimento, o que é confirmado na seguinte conclusão:

O sofrimento torna-se visível por meio de indicadores de mal-estar, tais como desgaste físico e mental e falta de reconhecimento, que é enfrentado mediante estratégias de mediação defensivas de negação e controle. O pressuposto inicial de que o modelo de produção fundamentado nos princípios tayloristas e na acumulação flexível de capital, preponderante no setor da construção civil, potencializa o sofrimento no contexto de produção é, então, confirmado. (Barros; Mendes, 2001, p. 63)

Como se pode notar, a subjetividade dos participantes toma uma posição de primazia sobre as condições do trabalho, mostrando-se fiel aos pressupostos da abordagem psicodinâmica. No entanto,

se compararmos com as abordagens individualistas, há menção ao contexto e uma recuperação do nexo entre saúde psíquica e trabalho.

Finalmente, nas abordagens psicossociológicas, sem perder de vista a multicausalidade, diagnosticar significa estar atento às condições internas e externas ao trabalho, em que todas constituem o bojo da sintomatologia apresentada, desde as nuances entre a situação de trabalho até as condições de vida do trabalhador. Lima (2006b), Jacques (2007), Sampaio, Codo e Hitomi (1995), entre outros autores, enfatizam como um elemento primordial na avaliação diagnóstica a questão epidemiológica que norteia a respeito da incidência de quadros típicos em determinadas categorias profissionais/ocupacionais, aspecto esse de suma importância na hora de emitir um parecer diagnóstico. É, pois, na interligação entre as condições laborais gerais e específicas da profissão, a organização do trabalho, a história e as condições de vida, que o psicólogo pode mapear e evidenciar o nexo entre o adoecimento e o trabalho. A esse respeito, Jardim e Glin (2000) enumeram uma série de questões para serem investigadas durante a anamnese ocupacional, tais como o próprio trabalho, a organização do trabalho, as exigências físicas, mentais e psicoafetivas, as condições de vida, a trajetória profissional e todas as nuances que perpassam esses tópicos básicos como ponto de partida da investigação. Além disso, como aponta Jacques (2003, 2007), o profissional pode lançar mão também de uma avaliação psicológica para identificar algumas alterações (intelectivas, sensoriais, etc.) que possam ter sido causadas pela exposição a agentes tóxicos, como é previsto na legislação previdenciária brasileira. Todavia, ainda são necessários parâmetros comparativos. A outra dificuldade, que está diretamente ligada com a anterior, é o desconhe-

cimento dos efeitos dos agentes tóxicos nas funções psíquicas.

Em referência ao dilema dos aspectos metodológico-instrumentais, as abordagens psicossociológicas adotam um conjunto de métodos na hora de realizar o diagnóstico. Borges e colaboradores (2007) afirmam que essas abordagens partem da tentativa de superação do dualismo entre a aplicação de técnicas qualitativas e quantitativas, e, por isso, aqueles que desenvolvem tais abordagens tendem a aplicar diversas técnicas metodológicas e, inclusive, a combinação do uso de técnicas para uma melhor aproximação da realidade. Entre as técnicas utilizadas estão: recursos técnicos estatísticos (com utilização de questionários estruturados), análise de conteúdo, análises documentais, registro de imagens, observação, entre outras. O importante é haver coerência entre objetivos, quadro teórico, desenho metodológico, definição adequada da população/amostra e/ou dos sujeitos, procedimentos de coleta de dados ou de acesso às informações e técnicas de análises de resultados. A composição de técnicas utilizadas deve facilitar ao psicólogo transitar do geral para o particular e vice-versa, bem como entre níveis de análises (individual, grupal, organizacional, ocupacional e conjuntural) e deve apoiar na distinção dos aspectos centrais daqueles mais secundários. Sato e Souza (2001) destacam a aplicação dos métodos etnográficos. Codo, Soratto e Menezes (2004) evidenciam a necessidade dessa flexibilidade ao afirmar que se deve considerar a interação entre técnicas qualitativas e quantitativas, focando os aspectos objetivos e subjetivos do trabalho, com estratégias semiclínicas (p. ex., estudo de caso), assim como estratégias de aplicação de escalas psicométricas, diários de campo e observações do pesquisador. A visão de homem deve ser sócio-histórica, inserida em um panorama econômico, político, social e cultural.

Nas abordagens psicossociológicas é praticamente consensual que não existe uma técnica única de fazer diagnósticos e pesquisa em saúde psíquica e trabalho. Entretanto Sampaio, Codo e Hitomi (1995), na tentativa de traçar um modelo de investigação, recomendam a adoção de algumas categorias básicas, de instrumentos que devem ser utilizados e certa sequência de etapas, que sintetizamos no Quadro 20.1. Entendemos que a proposta dos autores é aplicável aos diagnósticos ocupacionais, em geral de perspectiva epidemiológica. Portanto, não se pode generalizar para todo tipo de diagnósticos. Nessa proposta, há uma característica que merece destaque, ou seja, a ideia de o diagnóstico ter duas grandes fases: uma, de levantamento geral em que o uso de questionários estru-

turados ocupa o centro, e outra, de aprofundamento, recorrendo a entrevistas. Defendemos que tal proposta tornaria-se mais enriquecida se compreendemos essa segunda etapa apenas como uma fase de aprofundamento, em que se recorre mais à interpretação e à fala do trabalhador, de forma que se pode flexibilizar, no sentido de se considerarem as possibilidades de recorrer a outras técnicas, como os grupos focais, entre outras.

Ilustrando esse tipo de diagnóstico, tomamos como referência a pesquisa de Borges (2002, p. 92), cujo objetivo, no contexto rio-grandense-do-norte, foi responder a seguinte pergunta: “[...] Como os trabalhadores vêm reagindo à acentuação do processo da precarização do emprego no contexto local?”.

QUADRO 20.1

Modelo de investigação proposto por Sampaio, Codo e Hitoni (1995)

Categorias de investigação	Instrumentos	Etapas de pesquisa
• Categoria profissional ou ocupacional: descrever o segmento de trabalhadores que o diagnóstico focal. • Perfil de produção: descrever as formas como aquele segmento de trabalhadores produz suas condições de subsistência. • Jornada/salário: mapeamento dos aspectos que traduzem os ganhos econômicos e a extensão do investimento do trabalhador para obtê-los. • Processo de trabalho: descrição do modo de organização do trabalho típico do segmento de trabalhadores. • Formas de alienação no trabalho observadas que refletem os rompimentos entre o produto e o produtor, o controle do saber fazer, dos instrumentos e dos ganhos de produtividade. • Perfil de características psicológicas e psicopatológicas	• Revisão de literatura e fontes de dados • Dados demográficos e ocupacionais da categoria profissional e/ou ocupacional (população) • Documentos disponíveis de órgãos públicos e das empresas • Testes, inventários e questionários estruturados previamente testados • Protocolo de registro de observações (diretas ou por vídeo) do processo de trabalho • Diário de campo	• Identificação da categoria profissional e/ou ocupacional • Identificação da(s) organização(ões) • Abertura do campo (definição da forma de acesso ao trabalhador) • Estudos gerais sobre a categoria ocupacional • Montagem do perfil de produção • Etapa epidemiológica geral • Etapa de aprofundamento • Etapa de interpretação dos resultados gerais

Fonte: Os autores, com base em Sampaio, Codo e Hitomi (1995).

Responder essa questão exigiu uma leitura psicossociológica do fenômeno estudado, o que foi feito tendo como subsídio um apanhado de estudos desenvolvidos na cidade de Natal em categorias específicas, como bancários, profissionais da saúde, petroleiros, entre outros. Compreendeu-se que:

[...] os efeitos da precarização do emprego na saúde psíquica dos indivíduos variam em conformidade às especificidades concretas de cada categoria ocupacional e às práticas de gestão organizacional, entre outros aspectos, e de que é necessário e pertinente ter em conta aspectos afeto-cognitivos como motivação, satisfação e significado do trabalho, bem como valores humanos como indicadores de saúde psíquica.

[...] Problemas endêmicos exigem intervenções de natureza preventiva, as quais focalizem medidas coletivas e reflitam-se nas políticas públicas e organizacionais. (Borges, 2002, p. 105)

Sintetizando, essa pesquisa se propôs a trazer uma reflexão da necessidade de realização de análises nos níveis micro, meso e macro, de maneira que não só o indivíduo, a organização e a ocupação sejam alvos das discussões do nexo saúde psíquica e trabalho, mas que os cenários social, político e econômico ampliem as possibilidades de atuação e intervenção diante de uma visão de homem inserido em sua sociabilidade.

Promoção da saúde psíquica

Em Psicologia do Trabalho e das Organizações, ainda predominam ações de caráter “curativo”. Azevedo e Cruz (2006) sugerem que uma contribuição mais consistente por parte do psicólogo do trabalho deve incluir uma atitude “prevencionista”.

Nas organizações, em geral, os psicólogos são chamados para intervir no momento do surgimento de sintomas. Esses sintomas são entendidos como consequências negativas resultantes do processo de trabalho e comumente expressos em queixas das mais diversas ordens, como problemas referentes à queda na produtividade e relacionados à qualidade dos produtos, índices crescentes de absenteísmo e rotatividade, desencadeamento de doenças, aumento da frequência ou da gravidade de acidentes de trabalho, desmotivação, insatisfação, descomprometimento, entre outras. Se as intervenções ocorrem em caráter pontual, paliativo, sem uma investigação profunda das causas de sofrimento e doenças e sem o engajamento e apoio real dos principais dirigentes, intensifica-se a aplicação de estratégias de controle psicossocial com poucos resultados efetivos e duradouros para os trabalhadores. Além disso, a não consideração da multideterminação dos sintomas, que ocorre frequentemente, impede que se compreenda de modo profundo o sistema que ocasionou essas consequências e tende a levar a uma intervenção superficial.

De acordo com Chanlat (1996), a gestão de saúde em uma organização não difere muito do modo de gestão geral dela. Quanto ao aspecto preventivo destacado, ressaltam-se os seguintes enfoques:

1. Mudança de conduta e comportamento para a saúde no ambiente de trabalho.
2. Enfoque de saúde pública para influenciar os determinantes da saúde no ambiente de trabalho.
3. Prevenção como parte integrante da gestão moderna de saúde e segurança ocupacional.
4. Estratégia destinada a reduzir o absenteísmo relacionado a doenças.
5. Prevenção fazendo parte integrante da mudança organizacional.

Essa tipologia coincide, em linhas gerais, com o desenvolvimento histórico da prevenção. A maioria dos enfoques, na prática, continua centrada na mudança de conduta. Assim sendo, devido à falta de clareza conceitual existente até hoje, funções importantes da empresa, como a organização do trabalho e a gestão de pessoas, entre outras, não são incluídas no conceito de prevenção, apesar de indubitavelmente influírem na saúde e no bem-estar do trabalhador.

O significado do termo “promoção da saúde” foi mudando ao longo de tempo e, atualmente, associa-se a valores, tais como vida, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria e responsabilização mútua, uma vez que envolve ações do Estado, do sistema de saúde, dos indivíduos e das parcerias intersetoriais. Os conceitos de prevenção de doenças e de promoção da saúde não se distinguem claramente na prática do setor da saúde. As práticas em promoção da saúde, da mesma forma que as de prevenção de doenças, fazem uso do conhecimento técnico e científico específico do campo da saúde.

Programas de promoção da saúde têm sido especialmente dirigidos a empregados de organizações e são considerados eficientes do ponto de vista do mercado. Eles constituem um dos elementos estratégicos centrais no sentido de equilibrar a espiral crescente de gastos com assistência médica e hospitalar nas organizações. É um setor de atividade em expansão nos Estados Unidos, cujo modelo vem sendo crescentemente implantado no Brasil, inclusive por filiais de organizações americanas.

De forma geral, independentemente da abordagem adotada, as práticas preventivas e/ou de promoção da saúde por parte do psicólogo do trabalho e das organizações podem desenvolver-se em todos os níveis:

1. primário (proteção e promoção da saúde);
2. secundário (assistência); e
3. terciário (reabilitação e readaptação social).

Esses níveis demandam simultaneamente um trabalho político do psicólogo, no qual deve ser garantido o compromisso da instituição na implantação de mudanças e transformações nas situações de trabalho que impactam o processo saúde-doença.

A prevenção primária pretende intervir antes que surja algum problema e se articula por meio de um conjunto de medidas que visam, sobretudo, à educação para a saúde. Essas medidas não são voltadas para determinadas doenças, mas destinadas a aumentar a saúde e o bem-estar gerais (Buss, 2003). Em resumo, a prevenção primária é operacionalizada por meio de programas que objetivam evitar a ocorrência do problema-alvo, antes que ele se inicie. Zanelli (2010, p. 49), em seu ensaio sobre o estresse nas organizações, afirma que “O estabelecimento de um programa nos âmbitos decisórios é, sem dúvida, o mais relevante, por seu caráter preventivo”.

O National Institut of Occupational Safety and Health (NIOSH) (1999, 2007) recomenda que se privilegie a prevenção primária dos fatores de risco psicossociais no trabalho (FRPT), o estudo dos fatores pessoais, organizacionais e da interface indivíduo-organização, que influem na saúde ocupacional, as repercussões sociais e econômicas e a implantação de programas (de assistência ao empregado e à família-trabalho, entre outros). Embora os FRPTs e também os fatores de proteção para a saúde psíquica do trabalhador ainda não estejam suficientemente estabelecidos, já existe uma literatura substancial relacionando fatores da organização do trabalho (sobrecarga de trabalho, fragmentação de tarefas, incerteza

quanto ao futuro do emprego, pressão de tempo, altas exigências cognitivas e apoio social reduzido, entre outros) à etiologia dos agravos psicoemocionais relacionados ao trabalho (Moon, 1996).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (World Health Organization, 1984) define cinco princípios de abordagem da promoção da saúde, fundamentados no modelo ecológico. Esses princípios foram adaptados por Wynne (1989) para utilização no local de trabalho e estabelecem que a promoção da saúde:

1. Pode ser aplicada a todos os grupos de trabalhadores.
2. É dirigida às causas subjacentes da falta de saúde.
3. Combina diversos métodos de abordagem.
4. Tem como objetivo a participação efetiva dos trabalhadores.
5. Não é primariamente uma atividade médica, mas deve fazer parte da organização e das condições de trabalho.

Além disso, a promoção da saúde propõe uma combinação de estratégias: ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço de ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação) e de parcerias intersetoriais com a ideia de responsabilização múltipla e compartilhada.

A promoção de saúde no ambiente de trabalho engloba, ou deveria englobar, o conjunto de medidas adotadas por empregados, por empresários e pela sociedade para melhorar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. As ações de prevenção em saúde nem sempre são vistas como investimento por parte das empresas, o que significa que, na maioria das vezes, essas ações tendem a ser consideradas como custos.

Um documento divulgado pela OMS, de Mossink (2004), intitulado *Comprender y aplicar el análisis económico en la empresa*, voltado para empresas e empresários, aborda, a partir de uma visão econômica, os benefícios de tais ações para a empresa. O autor mostra que o investimento em saúde alcança muito além daquilo que a organização comumente contempla. As organizações de maior porte, pertencentes a setores mais dinâmicos da economia, tendem a ser mais pródigas nos benefícios e também são as que implantaram programas de promoção da saúde para seus trabalhadores (Teixeira; Bahia; Vianna, 2002).

Os programas tendem a ser desenvolvidos justamente nos grupos que apresentam menor risco. Os grupos mais desfavorecidos e de maior risco são os que não dispõem de recursos para entrar no mercado (Teixeira; Risi Junior, 1999). São obtidos benefícios para a sociedade, o sistema de saúde pública e o previdenciário, a família de cada trabalhador e a imagem da organização na ótica dos clientes externos, entre outros.

Apesar de algumas divergências, os autores concordam que a organização do trabalho pode apresentar-se como fator de fragilização mental dos indivíduos, o que torna as organizações corresponsáveis pela saúde psíquica de seus integrantes (Vasconcelos; Faria, 2007).

Tomando como base o conhecimento científico disponível e a experiência prática, podem ser identificados os seguintes fatores como essenciais para atividades eficazes de promoção:

1. Esforço interdisciplinar que implique numerosos e diferentes atores da empresa (saúde e segurança ocupacional, gestão de RH, gestão de qualidade, formação, entre outros).
2. Participação e cooperação de todos os atores.

3. Um enfoque de amplo alcance que associe as atividades orientadas para o trabalhador com as que abordam o desenho das condições de trabalho e da organização.

A prevenção secundária é um prolongamento da prevenção primária, cada vez que esta não alcançou os objetivos pretendidos. É uma intervenção especializada, endereçada àqueles trabalhadores que já manifestaram sinais ou sintomas ligados à saúde psíquica e visa a diminuir a prevalência do problema-alvo, buscando impedir sua progressão. Faz parte desse nível de intervenção uma variedade de técnicas: aquisição de conhecimento mais adequado a respeito do problema, conscientização de pessoas e grupos em relação a seu comportamento; suas reações às diversas circunstâncias; o significado das coisas que lhe acontecem e dos gestos que usam para determinadas situações.

A prevenção terciária corresponde às medidas adotadas após as consequências da incapacitação, representadas pela instalação de deficiências funcionais. Tem como objetivo essencial a reintegração do indivíduo na sociedade, possibilitando-lhe novas oportunidades de engajamento na escola, nos grupos de amigos, na família, no trabalho, entre outros. Objetiva, assim, diminuir as consequências de determinado agravo, já contínuo e intenso, sendo em geral utilizadas estratégias voltadas para a reabilitação e a reinserção social do indivíduo. A recuperação pode ser total ou parcial, por meio de processos de reabilitação e de aproveitamento da capacidade funcional remanescente. A fisioterapia, a reeducação, a terapia ocupacional e a readaptação à vida normal são as medidas mais frequentemente utilizadas nesse nível. No serviço público, existem os centros de referência em saúde do trabalhador (CERESTs) que devem de-

envolver ações nos três níveis citados, mas nem todos os CERESTs engendram ações dirigidas à saúde psíquica do trabalhador (Brasil, 2012).

A prevenção em seus três níveis – primário, secundário e terciário – é operacionalizada pelos psicólogos no campo da saúde psíquica e do trabalho, segundo as diferentes abordagens adotadas (individualista, psicodinâmica e psicossociológicas) como descrito neste capítulo. Passamos, então, a descrever como as ações preventivas variam segundo tais abordagens. As abordagens diferem entre si, principalmente quanto à importância atribuída às características do trabalhador *versus* condições de trabalho como causa principal de adoecimento. As denominadas “abordagens individualistas” privilegiam o quadro teórico cognitivo-comportamental e destinam ao trabalho o atributo de fator desencadeante do processo de adoecer, com maior ou menor grau de relevância. Postula-se que a forma como a pessoa lida com as circunstâncias geradoras de estresse exerce grande influência sobre sua saúde.

Uma tendência dos programas na área é a adoção de técnicas combinadas, com uso de relaxamento e técnicas cognitivo-comportamentais, implementadas em pequenos grupos, em sessões semanais. A abordagem denominada “multi-componente”, frequentemente utilizada, consiste na associação de abordagens e técnicas (Murphy, 1996). Os componentes investigados ou tratados podem ser, por exemplo, informação sobre causas e manifestações do estresse, inoculação de estresse, relaxamento, treino de assertividade, reestruturação cognitiva, manejo de tempo, suporte social, reestruturação cognitiva, manejo de raiva, treinamento em habilidades sociais, redução de tensão (p. ex., relaxamento, *biofeedback*). Para Murta e Tróccoli (2004), intervenções focadas no

trabalhador podem contribuir para a prevenção primária (promoção e prevenção de doenças) ao atuarem como ferramenta auxiliar em programas multidisciplinares de saúde no trabalho.

As intervenções focadas na organização são voltadas para a modificação de estressores do ambiente de trabalho, podendo incluir mudanças na estrutura organizacional, condições de trabalho, treinamento e desenvolvimento, participação e autonomia no trabalho e relações interpessoais no trabalho. Arranjos do ambiente organizacional produzem possivelmente resultados mais rápidos e eficazes na promoção da saúde (Stokols, 1992).

O maior número de publicações, principalmente em língua inglesa, na área da reabilitação psicossocial segue uma perspectiva cognitivo-comportamental (Bonetti; Carvalho, 2009), implicando uma prática profissional em que são frequentes modalidades individuais e grupais de intervenção. Por exemplo, com trabalhadores em reabilitação por uso e abuso de álcool e drogas (Rangé; Marlatt, 2008), usam-se principalmente as seguintes técnicas: fortalecimento da aliança terapêutica; monitoramento da atividade (matriz 2 x 2 de vantagens-desvantagens), diários de pensamentos enfrentados com respostas racionais e manejo de fissuras, tirando o foco dos impulsos (assistir à TV, fazer relaxamento) e dramatização para treino de assertividade, entre outros. Geralmente, os participantes são examinados por meio de questionários e escalas, antes e depois da intervenção, por vezes ocorrendo avaliações da intervenção. Os psicólogos devem fornecer *feedback*, educação, técnicas e apoio.

Utilizam-se frequentemente técnicas quantitativas de aferição, tais como questionários, escalas e outras. Parecem inexistir pesquisas voltadas para a prevenção primária ou secundária. Ocasionalmente, a

mídia publica ações de promoção de saúde no trabalho em grandes empresas, porém, sem uma avaliação sistemática de seus efeitos (Murta; Tróccoli, 2004).

Não há ênfase na prevenção primária (promoção e proteção à saúde), no entanto, existem diversos relatos de atividades relacionadas à prevenção secundária (assistência) e terciária (reabilitação) em trabalhadores. O maior número de publicações, principalmente em língua inglesa, na área da reabilitação segue essa abordagem (Bonetti; Carvalho, 2009).

No Brasil, a psicodinâmica do trabalho tem sido aplicada em duas perspectivas:

1. como categoria teórico-metodológica; e
2. como categoria teórica (Merlo; Mendes, 2009).

Na primeira, é definido o uso da teoria e do método fundamentado no que foi originalmente proposto por Dejours (1987, 2007), que pressupõe a indissolubilidade entre a pesquisa e a ação. Esse fundamento encontra-se na base da clínica do trabalho, que é, ao mesmo tempo, teoria e método. Para revelar o sofrimento por meio da fala-escuta, estão implicadas as interpretações conceituais e a ação pela fala. O sofrimento psíquico somente pode ser desvendado a partir de todas as etapas do método (Dejours, 2007):

1. pré-pesquisa (análise da demanda);
2. pesquisa propriamente dita (momento em que é discutida de modo coletivo a relação entre a organização do trabalho e a vivência do prazer e sofrimento);
3. validação dos resultados, incluídos os grupos de discussão com trabalhadores (nos moldes propostos pelo método) e identificação dos mecanismos de defesa construídos por esses trabalhadores, individual e coletivamente.

A segunda perspectiva está centrada nas discussões teóricas e no uso dos conceitos psicodinâmicos para delinear pesquisas empíricas, interpretar dados e estabelecer diálogos com outras abordagens. Vários estudos vêm sendo realizados nessa categoria, a despeito do método utilizado não ser a clínica do trabalho tradicionalmente proposta. Embora exista o objetivo de usá-la, muitos estudos não têm seguido tecnicamente à risca todos os passos do método original, realizando, no entanto, adaptações coerentes que, segundo Merlo e Mendes (2009), fortalecem o campo da clínica do trabalho no Brasil. Muitos estudos executados têm utilizado as categorias técnicas da psicodinâmica do trabalho para a compreensão da realidade de trabalho, o que permite uma interpretação mais aprofundada dos resultados de trabalho. Nessa categoria, no entanto, o método da clínica do trabalho não tem sido utilizado à risca: tem sofrido adaptações ou foi combinado com outras estratégias de coleta e análise de dados. Para Merlo e Mendes (2009), quanto mais essas técnicas aproximam-se do método estrito, mais fica possível a apreensão do objeto da psicodinâmica do trabalho, e, em contrapartida, quanto menos essa aproximação ocorre, mais os estudos são descritivos, com a identificação de indicadores, não permitindo a interpretação das relações intersubjetivas. Nessa perspectiva, pode-se fazer uso para a coleta de dados de entrevistas (individuais, coletivas, estruturadas, semiestruturadas), questionários, escalas, análise documental e observação sistemática. A análise de dados é predominantemente interpretativa e utiliza-se também da análise de conteúdo, do núcleo dos sentidos e da análise clínica do trabalho. Esses estudos têm permitido, por vezes, subsidiar políticas e ações de prevenção de riscos à saúde e de doenças mentais ocupacionais, sobretudo prevenção primária.

São raros os estudos existentes em reabilitação da capacidade laboral e reinserção ao trabalho utilizando essa abordagem. Um deles – um estudo de caso realizado por Rossi (2008) com quatro bancários portadores de Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) – analisa os problemas relacionados à reabilitação de trabalhadores. Utilizaram-se entrevista clínica e entrevista aberta para a coleta de informações, e os dados foram analisados segundo a ótica da clínica do trabalho e a análise do núcleo de sentido. Segundo a mesma autora, o método possibilitou produzir investigações e também se constituiu em um instrumento para intervenção, prevenção e transformação de processos de trabalho agressivos à saúde humana. Outro estudo realizado por Santos Júnior, Mendes e Araújo (2009) relata uma intervenção em clínica do trabalho aplicada em 13 bancários aposentados por invalidez, ressaltando a importância da possibilidade de ressignificação do sofrimento antes e após o adoecimento. Os autores destacam a realização desse tipo de intervenção como uma prática de prevenção dos riscos à saúde em diversos contextos de trabalho. A possibilidade da ressignificação (precoce) não geraria como consequência o adoecimento ou a cronicidade de uma alteração; portanto, age como prevenção primária e secundária fundamentalmente.

Com relação às abordagens psicossociológicas, elas não apresentam uma elaboração mais sofisticada tecnicamente de suas intervenções em nível de prevenção, assistência e reabilitação. No entanto, já há algumas práticas consolidadas na literatura. Primeiramente, julgamos importante assinalar que os adeptos dessa abordagem consideram as atividades diagnósticas um modo de intervenção e, não raro, desenvolvem tais diagnósticos no contexto de pesquisas. Decorrente dessa concepção do diagnóstico, desenvolvem práticas de

oferta de *feedbacks* em uma perspectiva de contribuir para a transformação social de instituições e/ou das condições de trabalho. Têm também uma atuação engajada junto a instituições sindicais, por exemplo, o que implica a aplicação de resultados de diagnósticos/pesquisas na elaboração de políticas públicas e políticas organizacionais, entre outras ações políticas de mudança nas condições de trabalho. Essas práticas são, portanto, de prevenção primária.

No nível de atuação organizacional, citamos que Buss (2003) e Zanelli (2010) mencionam o papel do desenvolvimento de programas nas organizações no campo da saúde psíquica e trabalho de caráter preventivo. Jaffe (1995) inclui estratégias de re-design das organizações e formulação de políticas organizacionais como estratégias de abordagem preventiva no campo. Há adeptos dessas abordagens também desenvolvendo atividades de clínica individual e grupal. Diferenciam-se de uma abordagem individualista porque o quadro de referência funda-se nos estudos epidemiológicos, no conhecimento do contexto ocupacional, entre outros. Exemplos dessas práticas são os citados anteriormente nas avaliações neuropsicológicas (Sato; Lacaz; Bernardo, 2006) que identificaram a intoxicação por mercúrio metálico. Aquele trabalho articulava ações diagnósticas, de assistência e de reabilitação do trabalhador e contribuições para a formulação de políticas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio a tantas divergências epistemológicas no cenário técnico-científico, consideramos fundamental a análise da prática, do agir do psicólogo, diante das principais questões sobre a saúde psíquica do trabalhador, seja no âmbito do diagnóstico, seja no encaminhamento das práticas de prevenção

e promoção de saúde psíquica. Primeiramente, perguntamos a que fim atende tais práticas? A resposta a essa pergunta nos remete às tensões mencionadas no início deste capítulo. Sem perder de vista a primordial função ética e de compromisso social do psicólogo, questionamos ainda até que ponto o agir do psicólogo está pautado em uma rigidez de análise muitas vezes oriunda da invisibilidade das tensões e do tão almejado nexo entre saúde psíquica e trabalho. A questão de fato parece ser a dificuldade do psicólogo de reconhecer em que campo de tensão ele se insere como especialista de uma prática, cujo olhar é influenciado pela diversidade que apontamos.

Destacamos que não existe um modo único, considerado certo e eficaz, de intervenção do psicólogo no campo da saúde psíquica e trabalho nas ações de diagnóstico, na prevenção e na promoção da saúde, bem como na assistência e na reabilitação. A adequação dos modos de ação está relacionada às perspectivas epistemológicas, aos quadros teóricos e aos temas focados. Esse ponto de vista deve, no entanto, ser interpretado cuidadosamente porque ele não significa execução descuidada das atividades do psicólogo, mas sim que exige coerência e fundamentação dentro da abordagem adotada pelo psicólogo. Desse modo, as tensões que, pelo próprio nome, podem sugerir conflitos existentes, também podem ser compreendidas como um processo de equacionar a diversidade de saberes na construção de uma prática ética na consolidação da atuação do psicólogo do trabalho, e não apenas uma tentativa isolada do seu agir diante das mudanças que estão ocorrendo no contexto laboral contemporâneo.

As práticas profissionais referentes à saúde psíquica e ao trabalho compõem-se de atividades ainda em consolidação no campo da Psicologia do Trabalho e das Organizações, no sentido de que requer

expansão na atuação lidando com políticas públicas, trabalhistas e nas organizações. Tal expansão pode ser mais oportuna nos períodos de aumento de oferta de emprego, haja vista que, apesar de contradição fundamental entre os interesses do capital e do trabalhador, são nesses momentos que as necessidades de manutenção dos quadros de pessoal evidenciam-se. Além disso, as possibilidades de expansão têm sido ampliadas pelas transformações sociais em relação aos estilos de gestão, de organização do trabalho e de novas tecnologias (tecnologias de informação e comunicação), uma vez que a demanda crescente por trabalhadores qualificados, aumentando o custo da substituição, também favorece o combate à rotatividade.

A expansão das atividades em saúde psíquica e trabalho também pode ser vista como uma oportunidade de o psicólogo vislumbrar maiores facilidades em fazer valer seu compromisso ético no que diz respeito tanto às possibilidades de se questionar sobre as consequências do que faz quanto por tais atividades poderem ser dirigidas à promoção da qualidade de vida das pessoas. A atuação reflexiva do psicólogo em ações de diagnóstico e promoção da saúde no trabalho e nas organizações pode significar também um balizador, sendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional dos trabalhadores e das organizações concretizado nos termos discutidos no Capítulo 2, em que o bom desempenho deve ser associado ao bem-estar das pessoas.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. Discuta pelo menos duas tensões presentes no cenário técnico-científico do campo da saúde psíquica no trabalho, abordando os pontos fundamentais relativos às posições diferentes ou antagônicas que lhes deram origem.
2. Discuta as principais diferenças entre as abordagens individualistas, psicossociológicas e da psicodinâmica do trabalho em relação à saúde psíquica do trabalhador.
3. Qual papel cabe ao psicólogo no diagnóstico da saúde psíquica do trabalhador? Discuta aspectos técnicos e éticos do agir do psicólogo presentes neste processo.
4. De que forma o psicólogo pode atuar para contribuir para a promoção da saúde psíquica das pessoas no trabalho e nas organizações?

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, P. R. *Bem-estar psicológico de servidores e funcionários técnico-administrativos de instituições de ensino pública e privada: indicadores e antecedentes*. Natal. 2008. 275 f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Programa Integrado de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal da Paraíba, Natal, 2008.
- ALVARO, J. L. *Psicología social: perspectivas teóricas y metodológicas*. Madrid: Siglo Veintiuno de España, 1995.
- ALVARO, J. L.; GARRIDO, A. Modelos de transición tras la FP-2 y cambio psicológico: un estudio longitudinal. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, v. 6, n. 16, p. 74-78, 1990.
- ALVARO, J. L. Ocupación y bienestar. In: GARRIDO, A. (Org.). *Sociopsicología del trabajo*. Barcelona: UOC, 2006. p. 113-132.
- ALVARO, J. L. et al. La psicología social, ¿debe ser más social o sociológica? Niveles de análisis en las ciencias sociales. In: ALVARO, J. L. et al. (Org.). *Introducción a la psicología social sociológica*. Barcelona: Editorial UOC, 2007. p. 17-24.